



REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE

Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé

CNERS

**Manuel de
Procédures**

2^e édition

Juin 2021

TABLE DES MATIERES

Remerciements	5
Sigles et Acronymes	6
Préface	7
Liste des Procédures.....	8

Introduction.....9

I. Procédure de Fonctionnement du CNERS10

1.1. CE1- Règlement Intérieur	10
1.1.1. Missions	10
1.1.2. Composition	11
1.1.3. Fonctionnement.....	11
1.2. CE2- Canevas analyse des protocoles	14
1.3. CE3- Canevas d'analyse des outils de recueil du consentement	17
1.3.1. Notice d'information aux patient(e)s.....	17
1.3.2. Formulaire de consentement	17
1.4. CE4- Référentiels pour la gestion des essais cliniques.....	17
1.4.1. Conception scientifique et conduite de la recherche.....	18
1.4.2. Recrutement des participants à la recherche	18
1.4.3. Soins et protection des participant(e)s à la recherche	18
1.4.4. Protection de la confidentialité des données du/de la participant(e) à la recherche	19
1.4.5. Processus de consentement éclairé	19
1.4.6. Considérations communautaires et relatives à la politique de santé du Sénégal.....	19
1.4.7. Suivi après avis favorable du Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé	20
1.5. CE5- Canevas d'évaluation et de management des essais cliniques	20
1.5.1. Préalables :	20
1.5.1.1. Définition d'un essai clinique (Guide de l'OMS sur les BPC/IHC/E6)	20
1.5.1.2. Qu'est ce qui constitue un essai clinique ?	20
1.5.1.3. Qui contrôle et surveille un essai clinique ?	20
1.5.1.4. Evaluation de la mise en œuvre d'un essai clinique	20
1.5.2. Eléments de revue d'un protocole d'essai clinique	21
1.5.2.1. Revue des objectifs de l'essai	21
1.5.2.2. Respect des règles éthiques des participant(e)s	21
1.5.2.3. La sécurité	21
1.5.2.4. Validité scientifique et médicale de l'essai.....	22
1.5.2.5. Validité méthodologique et absence de biais	22
1.5.2.6. Faisabilité de l'essai	22
1.5.3. Pré requis d'une étude clinique au sein d'une population :	23
1.5.3.1. Pertinence scientifique, médicale, sociale	23
1.5.3.2. La pathologie : ses moyens diagnostics et sa prise en charge thérapeutique.....	23
1.5.3.3. Epidémiologie :	23
1.6. CE6- Evaluation éthique simplifiée.....	23

1.6.1.	<i>Situations pouvant faire appel à une évaluation éthique simplifiée.....</i>	23
1.6.2.	<i>Critères d'identification de recherche à risque minimal.....</i>	23
1.6.3.	<i>Procédure d'évaluation simplifiée.....</i>	25
1.6.3.1.	<i>Procédures de dépôt pour une évaluation accélérée</i>	25
1.6.3.2.	<i>Procédures d'évaluation.....</i>	25
1.6.3.3.	<i>Cheminement et délai de l'évaluation éthique par voie accélérée.....</i>	26
1.6.3.4.	<i>Décision</i>	26
1.6.3.5.	<i>Transmission de la décision du CNERS</i>	26
1.7.	CE7- Guide de rédaction d'un avis du CNERS.....	26
1.7.1.	<i>Introduction</i>	26
1.7.2.	<i>Contenu de l'avis.....</i>	27
1.7.3.	<i>Structuration de l'avis.....</i>	27
1.8.	CE8- Respect de la confidentialité par les experts externes au CNERS.....	29
1.9.	CE9- Procédures de communication.....	30
1.10.	CE10- Suivi des essais cliniques.....	31
1.11.	CE11- Gestion des déclarations d'EIG	31
1.12.	CE12- Gestion des amendements	32
1.13.	CE13- Canevas de rédaction du rapport annuel	32
1.13.1.1.	<i>Introduction</i>	32
1.13.1.2.	<i>Développement.....</i>	32
1.13.1.3.	<i>Conclusion.....</i>	32
1.14.	CE14- Procédure de documentation et d'archivage	33
1.15.	CE15- Frais de soumission des protocoles.	33
1.15.1.	<i>Rappel des dispositions financières énoncées dans le décret 2009-729 portant création du CNERS</i>	33
1.15.2.	<i>Etude préalable des pratiques concernant les montants de frais de soumission.....</i>	34
1.15.3.	<i>Fixation des frais de soumission par le CNERS</i>	34
1.15.4.	<i>Gestion des montants versés</i>	35

II. Procédures de fonctionnement du Secrétariat du CNERS36

Introduction	36
2.1. SEC1- Document décrivant la procédure de réception d'un protocole de recherche	36
2.1.1.	<i>Soumission</i>
2.1.2.	<i>Exigences relatives à une demande d'examen.....</i>
2.2. SEC2- Procédure d'enregistrement des protocoles	37
2.3. SEC3- Procédure de gestion des demandes d'amendements	38
2.4. SEC4- Document de procédures de gestion des déclarations d'EIG	38
2.5. SEC5- Procédure d'archivage des documents	38

2.6.	SEC6- Fiche de recevabilité d'un protocole.....	39
2.6.1.	<i>Fiche de recevabilité d'un protocole de recherche.....</i>	<i>39</i>
2.6.2.	<i>Conditions à remplir par le(s) demandeur(s)</i>	<i>39</i>
2.6.3.	<i>Informations spécifiques.....</i>	<i>39</i>
2.7.	SEC7- Check- List Dépôt Protocole Recherche Biomédicale.....	41
2.8.	SEC8- Check- List Dépôt Protocole Sciences Sociales	41
2.9.	SEC9- Check- List Dépôt Protocole Médecine Traditionnelle	42
III.	Annexes	44
3.1.	Texte du serment des membres du CNERs et du secrétariat permanent.....	44
3.2.	Montants des frais de mission	44
3.3.	Loi n° 2009-17 Portant code d'éthique pour la recherche en santé	46
3.4.	Décret n° 2009-729 du 3-08-2009 créant le Comité d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERs)	56
3.5.	Organigramme du CNERs	61

Remerciements

La révision de ce manuel de procédures a été possible grâce à l'engagement d'une équipe composée de membres du CNERS et de personnes ressources, avec le soutien financier de EDCTP à travers le projet BCA-WA-ETHICS, SENETHICS et l'appui technique et administratif du Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Le CNERS remercie particulièrement les membres de cette équipe de révision dont les noms suivent :

- | | | |
|-------------------------|---------|---|
| • Pr Anta Tal | DIA | Présidente du CNERS ; |
| • Dr Aïssatou | TOURE | Vice-Présidente du CNERS ; |
| • Dr Samba Cor | SARR | Secrétaire permanent du CNERS ; |
| • M. Mohamadou Lamine | MANE | Gestionnaire du CNERS ; |
| • Dr Aldiouma | DIALLO | Membre du CNERS ; |
| • Mme Yéya Birane | WANE | Membre du CNERS ; |
| • M. Ousmane | DIOUF | Responsable suivi des protocoles au CNERS ; |
| • Mme Nd. Mingue Ndiaté | NDIAYE | Coordonnatrice Cellule Genre/MSAS ; |
| • Mme Viviane M.S. | MBENGUE | Division de la Recherche/DPRS/MSAS ; |
| • Dr Zeyni El Abidine | SY | Division de la Recherche/DPRS/MSAS ; |
| • M. Abib | NDIAYE | Division de la Recherche/DPRS/MSAS ; |
| • Mme Farah | NABIL | Administratrice du projet BCA-WA-ETHICS. |

Sigles et Acronymes

BPC	Bonnes Pratiques Cliniques ;
BPF	Bonnes Pratiques de Fabrication ;
BPR	Bonnes Pratiques de Recherche ;
CNERS	Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé ;
CSDT	Comité de Surveillance des Données de Tolérance ;
DPL	Direction de la Pharmacie et des Laboratoires ;
DR	Division Recherche ;
DS	Direction de la Santé ;
EIG	Evènements Indésirables Graves ;
CIH	Conférence Internationale d’Harmonisation ;
OMS	Organisation Mondiale de la Santé ;
PI	Investigateur Principal ;
POS	Procédures Opératoires Standardisées
SP	Secrétaire permanent

Préface

Le Comité national d'Ethique pour la Recherche en Santé est un organe de régulation mis en place par la loi 2009-17 du 09 mars 2009. Pour son fonctionnement, il a besoin de se doter de procédures et d'outils pour une gestion efficace de ses activités.

Dans cette dynamique, un manuel de procédures a été élaboré en 2009 et mis en application à partir de 2011. Son utilisation a permis d'avoir une gestion productive et centrée sur le respect scrupuleux des principes éthiques et des standards de management des comités d'éthique recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé.

Le champ d'intervention du CNERS est particulièrement marqué par l'émergence régulière de nouvelles problématiques nécessitant la création et l'intégration de compétences adaptatives pour s'ajuster aux nouveaux défis soulevés et répondre avec efficacité aux demandes formulées par les chercheurs.

A l'évaluation de la première version du manuel de procédures, il est apparu un gap dans la prise en compte des défis nouveaux en lien avec le transhumanisme, l'intelligence artificielle, le genre, etc. Pour y remédier, le comité, avec l'appui de personnes ressources, a procédé à la révision dudit document pour intégrer des dispositions et des méthodes permettant une évaluation conforme aux exigences actuelles et à la gestion des dilemmes éthiques.

En effet, outre la transparence et la responsabilité, le fonctionnement du CNERS est basé sur une démarche qualité avec comme particularités la traçabilité et le référencement de tous les procédures et outils utilisés.

Le document ainsi révisé va servir de support aux membres du Comité d'Ethique pour une prise en compte des nouveaux défis en lien avec l'avancée de la science et les transformations sociétales.

Au regard de l'importance de ce document dans le fonctionnement efficace du CNERS, j'invite tous les membres à en faire un usage régulier.

Pr. Anta Tal DIA

Pr. Anta Tal DIA
Présidente CNERS
La Présidente



➤ **Procédures du Comité d'éthique**

- CE1- Règlement Intérieur ;
- CE2- Canevas d'analyse des protocoles ;
- CE3- Canevas d'analyse des outils de recueil du consentement ;
- CE4- Référentiels pour la gestion des essais cliniques ;
- CE5- Canevas d'évaluation et de management des essais cliniques ;
- CE6- Evaluation éthique simplifiée ;
- CE7- Guide de rédaction d'un avis du CNERS ;
- CE8- Respect de la confidentialité par les experts externes au CNERS ;
- CE9- Procédures de communication ;
- CE10- Suivi des essais cliniques ;
- CE11- Gestion des déclarations d'EIG ;
- CE12- Gestion des amendements ;
- CE13- Canevas de rédaction du rapport annuel ;
- CE14- Procédure de documentation et d'archivage ;
- CE15- Frais de soumission des protocoles.

➤ **Outils du Secrétariat du Comité d'éthique**

- SEC1- Document décrivant la procédure de réception d'un protocole de recherche ;
- SEC2- Procédure d'enregistrement des protocoles ;
- SEC3- Procédure de gestion des demandes d'amendements ;
- SEC4- Document de procédures de gestion des déclarations d'EIG ;
- SEC5- Procédure d'archivage des documents ;
- SEC6- Fiche de recevabilité d'un protocole
- SEC7- Check- List Dépôt Protocole Recherche Biomédicale
- SEC8- Check- List Dépôt Protocole Sciences Sociales
- SEC9- Check- List Dépôt Protocole Médecine Traditionnelle

Introduction

Issue de la théorie micro-économique et de la science administrative anglo-saxonne, la notion de « bonne gouvernance » a été diffusée dans les années 1990, par la Banque Mondiale, comme la condition nécessaire des politiques de développement. Dans le contexte de la coordination de la recherche, la gouvernance est appelée pour fournir l'orientation stratégique, afin de s'assurer que les objectifs proposés sont réalistes et sont susceptibles d'être atteints, que les risques sont gérés de manière adéquate et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable.

Dans cette dynamique, le Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) veille en priorité au respect des intérêts des ayants droits (participants à des recherches, citoyens, pouvoirs publics, partenaires, actionnaires...) et œuvre à faire en sorte que leurs droits soient respectés dans la conception et la mise en œuvre des protocoles de recherche. Cette exigence de gouvernance consacrée par la loi n° **2009-17 du 09 mars 2009** et le décret **2009-729 du 3 août 2009** appelle de la responsabilité et de la transparence dans l'organisation et le fonctionnement du CNERS.

Cette responsabilité dont il est question est l'obligation de répondre de ses actes, d'être garant des décisions prises conformément aux textes de fonctionnement du comité et d'assumer ses engagements. Elle a pour conséquence, chez les membres du comité national d'éthique, le devoir de veiller au respect des principes éthiques dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets de recherche, à la protection des droits des personnes participant à une recherche au Sénégal. Quant à la transparence, elle reste le deuxième indicateur d'évaluation de la performance fonctionnelle du CNERS. Elle est utilisée pour qualifier une pratique sociale guidée par la sincérité, l'objectivité et une parfaite accessibilité de l'information utile pour permettre aux membres de faire face à leurs obligations. La transparence est l'une des principales exigences des citoyens, et de tous les autres acteurs de la recherche à l'égard du CNERS. Le défi pour cet organe de gouvernance est de trouver l'équilibre entre ce qui doit être dévoilé et ce qui ne doit ou ne peut l'être.

Pour permettre aux membres du CNERS de s'acquitter avec efficience et efficacité des obligations visées ci-dessus, ce manuel de procédures est ainsi élaboré.

I. Procédure de Fonctionnement du CNERS

1.1. CE1- Règlement Intérieur

1.1.1. Missions

Article premier : Le présent règlement intérieur précise les missions et le fonctionnement du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé, créé par la loi n° 2009-17 du 09 mars 2009 portant Code d’Ethique pour la Recherche en Santé.

Art. 2 : Le CNERS se prononce sur la validité éthique et scientifique des protocoles de recherche soumis à son appréciation. Il notifie aux requérants les questions éthiques liées à la recherche en santé en général.

Outre l’examen et l’approbation des protocoles de recherche, le CNERS peut, sur demande des autorités sanitaires et des acteurs sociaux (médecins, chercheurs, personnels de santé, patients, acteurs sociaux concernés par la santé), donner des avis, proposer des réflexions, publier des documents sur les questions éthiques et scientifiques liés à la recherche en Santé qui lui sont soumises, en particulier à propos des recherches en cours. Ledit comité peut également évaluer les projets d’articles dont les protocoles de recherche ou les procédés de collecte de données n’avaient pas été soumis préalablement à son examen.

Art. 3 : Le CNERS met à la disposition des chercheurs un document d’informations sur les conditions de soumission de leurs protocoles et ou projets d’articles.

Art. 4 : Le CNERS a également pour mission de diffuser dans la société les informations aux participants à des recherches et susceptibles de promouvoir des débats sur les questions éthiques dans la perspective d’une meilleure prise en charge des problèmes de santé et en vue de rendre toute recherche respectueuse des principes édictés par la loi portant code d’éthique pour la recherche en santé.

Art. 5 : Le CNERS peut susciter un processus en vue de l’élaboration d’une charte nationale sur l’éthique en santé.

Art. 6 : Le CNERS est chargé de constituer un fonds documentaire pour favoriser la réflexion, développer la formation et la sensibilisation de la société sur les questions éthiques en santé et sur l’importance de la recherche dans le développement d’un système de santé performant. En particulier, il rassemble une documentation générale sur les questions éthiques et une documentation spécifique sur l’Afrique par l’acquisition de documents et par l’utilisation des ressources informatiques qui permettent de contacter les centres spécialisés dans le domaine de l’éthique.

Art 7 : Le CNERS peut être saisi par des personnes physiques ou morales, et mener des investigations en cas d’informations signalant un déroulement anormal d’un protocole de recherche en santé, afin de conseiller le Ministre chargé de la Santé sur les décisions à prendre.

Art. 8 Le CNERS contribue à identifier les lacunes dans le dispositif législatif et réglementaire dans le cadre de la recherche et de la pratique médicale. Il pourra faire des propositions pour combler les éventuels vides juridiques.

1.1.2. Composition

Art. 9 : Le CNERS est composé de :

- Un président ;
- Un vice-président;
- Un secrétaire permanent,
- Trois présidents de commissions
- Autres membres.

Art. 10 : Le secrétariat est coordonné par un secrétaire permanent assisté de points focaux :

- Chargé de suivi des protocoles ;
- Chargé du suivi des activités de formation et de sensibilisation en éthique de la recherche ;
- Chargé de la gestion financière et de la comptabilité matières.

Art. 11 : les commissions sont :

- Une commission de suivi des protocoles de recherche ;
- Une commission de formation, de documentation et de sensibilisation en éthique de la recherche ;
- Une commission des finances et de la comptabilité.

Les membres du CNERS peuvent s'inscrire dans une commission de leur choix, mais sont aussi invités à apporter leur concours aux travaux entrepris dans les autres commissions.

Une fiche de poste sera établie pour chaque membre du secrétariat permanent.

1.1.3. Fonctionnement

Art. 12 : Les références et éléments d'évaluation des protocoles sont :

- Les conventions et déclarations internationales relatives aux principes éthiques de la recherche, du respect des droits humains et de la protection de l'environnement et de ses dérivés (Cf. visas de la loi et du décret) ;
- Les sources législatives et réglementaires en vigueur au Sénégal ;
- Les réalités socioculturelles spécifiques aux différentes personnes à enrôler dans les études ;
- Les bonnes pratiques cliniques (BPC/ICH/E6) ;
- Les documents de référence de la politique publique de santé, d'environnement et développement économique et social ;
- Les avis d'experts.

Art. 13 : Le CNERS se réunit sur convocation de son président ou, en son absence, du vice-président, en session ordinaire de revue de protocoles au moins une fois par mois et en session extraordinaire en cas de besoin. Le nombre minimum de protocoles par session est de cinq (5).

Le président, ou, en son absence, le vice-président, dirige les réunions et signe les délibérations concernant les protocoles pour lesquels les avis du CNERS ont été sollicités. En absence de ces deux, les membres présents désignent en leur sein un président de séance qui signe le procès-verbal.

Le CNERS peut recourir à la procédure d'évaluation éthique simplifiée telle que définie à la fiche CE6 en cas de besoin.

Art. 14 : Les membres participent aux sessions d'examen des protocoles et s'engagent à respecter le secret des délibérations. Ils se prononcent librement sur les protocoles soumis au CNERS. Les membres directement ou indirectement impliqués dans l'élaboration et la réalisation d'un protocole présenté ne prennent pas part aux débats et délibérations concernant ce protocole. Ils peuvent être entendus, à titre exceptionnel, pour donner des éclaircissements techniques sur le protocole.

Les membres concernés par cette situation sont tenus de signer la fiche de déclaration de conflit d'intérêt élaborée à cet effet.

Art. 15 : Pour les avis du CNERS, un consensus est souhaitable. À défaut, un vote est organisé et les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.

Art. 16 : Le secrétariat du CNERS réalise l'archivage complet de ses travaux et correspondances et a la charge de constituer un fonds documentaire qui sera à la disposition des membres dans l'exercice de leur mandat.

Art. 17 : Les ressources du CNERS proviennent :

- De l'Etat ;
- Des frais de soumission ;
- Des autres partenaires.

Art 18 : Les ressources financières du CNERS sont utilisées selon les rubriques suivantes :

- Achat de fournitures et d'équipements de bureau ;
- Achat de ressources documentaires nécessaires pour le travail du CNERS lors de l'évaluation des protocoles et pour les formations qu'il doit assurer ;
- Soutien logistique (achat de véhicules, d'ordinateurs, appui aux voyages d'études, motivation des experts etc.) ;
- Indemnité mensuelle de motivation des membres du secrétariat fixée au prorata des responsabilités et tâches ;
- Prise en charge des membres du CNERS lors des réunions d'examen de protocole ou à l'occasion de tâches qui seront spécifiquement dévolues à certains membres, sur une base contractuelle (rédaction de rapports, préparations de formations, etc.) ;
- Suivi et évaluation sur le terrain des protocoles de recherche mis en œuvre ;

Art 19 : Un calendrier annuel est élaboré pour préciser les dates approximatives retenues pour les sessions. La soumission de protocoles pour évaluation se fait à travers la plateforme électronique intégrée au site web : www.cners.sn.

Ce dépôt doit se faire au moins vingt (20) jours avant la date de la réunion pour une probable programmation. Le secrétariat permanent est chargé de faire parvenir les protocoles aux membres de la session dix (10) jours auparavant. Les sessions peuvent se tenir en présentiel ou en mode virtuel.

Sur la base des résumés des protocoles inscrits, le secrétariat permanent, en rapport avec le président du CNERS, identifiera au besoin des experts susceptibles d'apporter un éclairage technique. (Ces experts pourront être invités à présenter leur rapport lors de la session du CNERS.)

Art 20 : Le secrétariat permanent fait parvenir au plus tard une semaine après la réunion, par voie électronique, le draft de procès-verbal de la session aux membres présents, pour avis, en veillant à ne pas communiquer aux chercheurs membres du CNERS les observations relatives aux protocoles auxquels ils sont associés et pour lesquels ils n'ont pas pris part à

l'examen. Ces derniers ont deux jours après réception du courrier pour proposer leurs corrections et observations qu'ils font partager aux membres présents à la session. Après intégration des diverses observations et signature du procès-verbal définitif, le secrétariat permanent est chargé de faire parvenir aux promoteurs les avis retenus signés par le Président ou en cas d'absence le Vice-Président, au plus tard quinze (15) jours après la réunion.

Art. 21 : Le président du CNERS dirige les réunions, signe les procès-verbaux et autorise le Secrétaire Permanent à notifier aux responsables des recherches les avis du CNERS. En cas d'absence de la Présidente, se conférer à l'article 13 dudit règlement intérieur.

Art. 22 : Le CNERS émet des avis et des recommandations sur les protocoles qui lui sont soumis.

Les avis définitifs du CNERS sont transmis au Ministre chargé de la Santé qui donne son autorisation ou non. Le président du CNERS ou par délégation le secrétaire permanent notifie aux auteurs des protocoles dans les quinze jours suivants la date de délibération l'avis définitif retenu par le comité.

Art. 23 : Les procès-verbaux définitifs des sessions sont envoyés à tous les membres du CNERS et archivés par le secrétariat du CNERS avec toutes les autres pièces relatives aux protocoles étudiés.

Art. 24 : Pour les sessions virtuelles, les membres invités à la revue sont tenus de transmettre au secrétariat permanent au moins 24 heures avant la réunion, leurs commentaires écrits. Le SP est appelé à en faire une synthèse partagée lors de la session délibérative.

Art. 25 : Le CNERS peut solliciter, au besoin, l'avis d'un expert extérieur sur les points inscrits à l'ordre du jour. Cet avis peut être exposé lors de la réunion du CNERS ou transmis au président du CNERS qui doit le communiquer le plus tôt possible aux membres avant la réunion.

Art. 26 : L'avis du CNERS peut être favorable ou défavorable. Au cours du processus d'évaluation, le CNERS peut être amené à solliciter des compléments d'information ou des modifications à apporter sur le protocole avant d'émettre un avis définitif.

En cas de réserves émises sur le fond d'un protocole, un autre examen par le CNERS est requis.

Les avis défavorables sont toujours motivés. En cas de rejet d'un protocole, le chercheur concerné peut faire appel par écrit et le CNERS est tenu de répondre par écrit ou d'organiser une audience avec ce dernier pour des explications. En tout état de cause, la dernière décision revient au CNERS.

Art. 27 : Les auteurs de protocoles qui passent outre l'avis du CNERS ou mettent en œuvre des protocoles sans l'avis favorable du CNERS s'exposent aux sanctions prévues par la loi.

Art. 28 : Le CNERS veille au suivi de la réalisation des protocoles et au respect des principes éthiques. Le chercheur dont le protocole a été approuvé est tenu de rendre compte immédiatement de tout incident majeur survenant dans le déroulement de l'étude. L'auteur du protocole s'engage par ailleurs à déposer un rapport sur les résultats de la recherche et sur les questions éthiques ou les problèmes soulevés durant la recherche. Les membres du CNERS impliqués dans la réalisation d'un protocole ne peuvent pas participer à l'examen et au processus de suivi dudit protocole.

Art. 29 : Le CNERS peut être saisi par tout acteur de la recherche à propos d'un problème éthique, même si l'étude a été entamée ou menée avant la mise en place du CNERS.

Art. 30 : Le CNERS peut également être saisi par tout participant à une recherche qu'il a autorisée à propos de problèmes soulevés lors de sa réalisation. Le CNERS donne conseil et assistance en ce cas et contacte à ce sujet l'investigateur principal de l'étude et veille à la résolution du problème posé par les services compétents.

Art. 31 : Un rapport annuel d'activités du CNERS visé par son président est remis au Ministre chargé de la Santé. L'élaboration dudit rapport est faite à partir du compendium des procès-verbaux, des avis émis et des rapports sur les autres activités.

Art 32 : Le président du CNERS peut convoquer des réunions avec un groupe restreint pour l'examen de protocoles présentant un caractère urgent. Les modalités de convocation de ces réunions sont définies dans les procédures opératoires standardisées du CNERS.

Art. 33 : Le CNERS se dote de tous les instruments utiles pour l'accomplissement de ses missions. Il participe à des rencontres et à des formations nationales et internationales sur les questions éthiques. Il peut également initier des activités du genre.

Art. 34 : Le CNERS a son siège au sein du Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Adresse : Rue Aimé Césaire, Dakar, Fann, BP. 4024 ;

Téléphone : 221 33 865 9810 / 221 773614212;

Site web : www.cners.sn ;

E-mail : cners@cners.sn

1.2. CE2- Canevas analyse des protocoles

Comme le souligne le guide de présentation des protocoles, les recherches doivent contribuer à améliorer la santé de la société sénégalaise. Elles peuvent aussi apporter des résultats généralisables et utiles pour d'autres pays, voire donner lieu à des applications universelles. Pour les études multicentriques, il est demandé de veiller au respect des intérêts nationaux et à la protection des participants à l'étude, surtout des groupes vulnérables.

Pour l'évaluation des protocoles, les membres du CNERS reçoivent au moins sept (07) copies via la plateforme ou par WeTransfer quinze (15) jours avant la session. Ils sont appelés à envoyer au secrétaire permanent leurs commentaires par mail au plus 24heurs avant la session. Ce dernier fait la synthèse et procède à la lecture du document lors de la réunion d'évaluation qui se fait en distanciel. Le procès- verbal synthétisant les conclusions de la session est partagé et validé via internet.

Pour aider à l'analyse des protocoles, les membres du CNERS s'appuient sur le canevas d'analyse suivant.

Titre du protocole :

Parties et contenus du Protocole	Critères d'évaluation	Oui	Non	NA	Appréciations
Problématique du Protocole					
Pertinence et niveau de priorité du thème de recherche	• Le thème est-il pertinent par rapport aux objectifs du Plan National de Développement Sanitaire et Social (2019-2028) et du Plan Stratégique national de la Recherche pour la Santé (2020-2023) ; • Le thème est-il prioritaire par rapport aux problèmes de santé des femmes, des hommes, et des populations vulnérables ? • Le thème est-il nouveau et tient-il compte des travaux déjà réalisés ? • Le thème tient-il compte des différences liées aux besoins spécifiques des hommes et des femmes ?				
Perspective de la Recherche	• Dans quelle perspective se situe la recherche ? Est-elle fondamentale ou opérationnelle ? • S'agit-il d'une recherche opérationnelle pouvant servir à orienter ou réorienter les programmes nationaux ? • L'étude concerne-t-elle l'échelle nationale, régionale ou le niveau du district sanitaire ou niveau communautaire, d'une ou de plusieurs structures sanitaires, publiques ou privées ? • S'agit-il d'une recherche avec une perspective, explorant les différentes expériences et besoins des femmes et des hommes ? • S'agit-il d'une recherche menée au sein d'une institution reconnue ?				

Méthodologie et contenu du protocole					
Objectifs, hypothèses de recherche et Outils de collecte	• Clarté et précision des objectifs : Les objectifs découlent-ils de la problématique ? • Les objectifs sont-ils réalisables dans le cadre de la recherche ? • Les hypothèses sont-elles bien formulées par rapport aux objectifs et à la problématique ? • Les outils de collecte sont-ils annexés ? - Si non, les éléments à collecter sont-ils clairement décrits ? • Si elle est prévue, l'étape d'un éventuel pré test est-elle clairement décrite ? • Les besoins et les expériences des femmes et des hommes de tous âges ont-ils été pris en compte dans la formulation du but et des objectifs de la recherche ?				
Responsables de la recherche	• Le chercheur principal et les autres investigateurs sont-ils nommément cités ? • Leurs contributions à l'étude sont-elles décrites ? • Existe-t-il un équilibre entre les hommes et les femmes dans l'équipe de recherche ?				
Compétences du ou des chercheurs par rapport au sujet	• Le profil du chercheur responsable qui présente le projet répond-il aux exigences de la recherche ? • À quelle institution ou service appartient-il ? • Les autres chercheurs sont-ils qualifiés pour leurs tâches dans la recherche ?				
Plan de collecte et d'analyse					
Validité des instruments	• Le plan de collecte et d'analyse est-il proposé ? • L'instrument est-il pertinent par rapport aux objectifs de l'étude ?				

	• La planification de la collecte des données est-elle bien décrite et cohérente ? • Les outils de collecte de données capturent-ils les variables spécifiques de la population étudiée ?	
Durée de la recherche	• Un calendrier, avec les dates prévues pour les diverses étapes, est-il inclus ? • La durée de la recherche permet-elle d'obtenir les résultats attendus de manière à résoudre les questions posées par la recherche ?	
Echantillonnage	• La population choisie selon les critères d'inclusion est-elle pertinente par rapport aux objectifs de l'étude ? • Le procédé d'échantillonnage découle-t-il des objectifs et hypothèses ? • L'échantillonnage est-il représentatif des hommes, des femmes et des groupes vulnérables ? • Le plan d'échantillonnage permet-il de valider l'étude et d'interpréter les résultats ?	
Analyse des données	• Le plan d'analyse est-il inclus dans le protocole ? • Les techniques d'analyse sont-elles pertinentes par rapport aux objectifs et aux hypothèses de l'étude ?	
Utilisation des résultats	• Existe-t-il un plan de publication et de dissémination des résultats de la recherche ? - Sous forme de publications ou de travaux académiques ? - Sous forme de restitutions aux autorités sanitaires et/ou aux personnes incluses dans la recherche ? • Un plan de dissémination des résultats est-il envisagé ? • Est-il prévu que la recherche donne lieu à des recommandations ? • Est-il mentionné que les résultats seront diffusés dans le but d'obtenir des impacts équitables sur la santé de tous les patients ? • Les résultats de la recherche seront-ils communiqués et partagés avec les groupes de population ayant participé de façon équitable ?	
Ethique de la recherche et protection des personnes	• Un chapitre relatif à l'éthique est-il inclus dans le protocole ? • Les considérations éthiques présentées par l'auteur respectent-elles les principes énoncés dans les textes de référence et les chartes éthiques connues ? • Les intérêts et la protection des sujets à l'enquête par rapport aux éventuels désagréments que pourrait entraîner l'étude sont-ils assurés ? • Les formulaires de consentement éclairé sont-ils spécifiés selon les situations ? • Les modalités de recueil du consentement sont-elles bien décrites ? • La conservation des données relatives à l'étude (données personnelles, prélèvements biologiques) est-elle prévue ? • Selon quelles modalités le respect de la confidentialité et les données personnelles relatives aux participants de l'étude seront-ils protégés, et éventuellement accessibles à celles-ci ? • Les participants à l'étude seront-ils bien informés sur leurs droits, dont celui de se retirer de l'étude sans subir de préjudice ? • Le monitoring de la recherche et les processus de signalement des incidents éventuels sont-ils prévus de manière satisfaisante ? • Les différences entre les risques et les avantages potentiels liées aux hommes et aux femmes de participer à une recherche sont-elles mentionnées ? • Le protocole mentionne-t-il les mesures prévues pour éviter tout préjudice social potentiel de façon différente lié aux hommes, aux femmes et aux groupes vulnérables ?	

Appréciation générale sur le protocole :

.....

.....

.....

1.3. CE3- Canevas d'analyse des outils de recueil du consentement

1.3.1. Notice d'information aux patient(e)s

N°	Critères d'évaluation	Oui	Non
1	Notification qu'il s'agit d'un protocole de recherche		
2	Objectif de l'étude		
3	Modalité d'allocation du traitement		
4	Explorations liées à l'étude (en plus des soins usuels)		
5	Responsabilités du patient		
6	Aspect expérimental de l'étude		
7	Risques et inconvénients prévisibles		
8	Bénéfices attendus		
9	Les différents bénéfices et les risques pour les hommes, les femmes et les groupes vulnérables, le cas échéant		
10	Autres traitements possibles		
11	Indemnisations et/ou traitements disponibles si des dommages liés à l'essai surviennent		
12	Indemnisation du participant (si prévue)		
13	Dépenses prévisibles pour le participant		
14	Participations volontaires, refus possible et droit de se retirer de l'étude		
15	Autorisation d'accès au dossier médical, dans le respect de la confidentialité, par les autorités, le comité d'éthique, les moniteurs et auditeurs		
16	Anonymisation des données cliniques du patient en cas de publications		
17	Assurance de la transmission de toute information nouvelle pertinente pouvant influencer la poursuite de la participation à l'étude		
18	Noms et coordonnées des personnes à contacter pour des informations complémentaires sur l'étude et en cas de problème		
19	Liste des circonstances prévisibles d'interruption du traitement		
20	Durée prévue de la participation		
21	Effectif approximatif de l'essai		

1.3.2. Formulaire de consentement

N°	Critères d'évaluation	Oui	Non
1	Bref résumé du projet, notification que les bénéfices et les inconvénients ont été expliqués.		
2	Existe-t-il différents formulaires de consentement pour les femmes et les hommes ?		
3	Mentionner : - Le participant a lu et compris les informations ; - Comprend qu'il peut poser des questions dans l'avenir ; - Consent librement à participer et l'atteste en signant le document.		
4	Identité et signature datée de l'investigateur.		
5	Identité et signature datée du participant à l'étude.		
6	Témoin impartial : identité et signature datée.		
7	Deux exemplaires ; participant et promoteur		

1.4. CE4- Référentiels pour la gestion des essais cliniques

Les bonnes pratiques cliniques (BPC/ICH/E6 constituent les référentiels techniques du CNERS en matière de gestion des essais cliniques. En outre, les points suivants doivent être pris en compte, selon le cas :

1.4.1. Conception scientifique et conduite de la recherche

1. Adéquation de la conception de la recherche par rapport à ses objectifs, à la méthode statistique (y compris le calcul de la taille de l'échantillon et de l'analyse) et à la possibilité de parvenir à des conclusions valides avec le plus petit nombre possible de participants à la recherche ;
2. Justification des risques et inconvénients pour les hommes et pour les femmes, prévisibles au regard des bénéfices attendus pour les participant(e)s à la recherche et les communautés concernées ;
3. Justification de l'emploi de groupes témoins ;
4. Justification de l'exclusion des femmes ou des hommes de l'étude, le cas échéant ;
5. Critères de retrait prématuré des participants à la recherche ;
6. Critères de suspension ou d'interruption définitive de la recherche ;
7. Adéquation des dispositions prises pour le monitoring et l'audit de la recherche, y compris la constitution d'un comité de surveillance des données de tolérance (CSDT)/DSMB ;
8. Adéquation du site de recherche, notamment du point de vue du personnel, des locaux disponibles et des procédures d'urgence ;
9. Procédure par laquelle les résultats de la recherche seront rapportés et publiés.

1.4.2. Recrutement des participants à la recherche

1. Caractéristiques de la population dont seront issus les participants à la recherche (socio-économiques et sociodémographiques) ;
2. Moyens par lesquels le contact initial et l'inclusion seront conduits ;
3. Moyens par lesquels une information complète sera transmise aux participants potentiels ou à leurs représentants ;
4. Critères d'inclusion des participants ;
5. Critères d'exclusion des participants.

1.4.3. Soins et protection des participants à la recherche

1. Pertinence des qualifications de l'investigateur (des investigateurs et expérience de celui-ci) pour la recherche proposée ;
2. Plans éventuels de retrait ou de suspension des traitements usuels aux fins de la recherche et justification d'une telle action ;
3. Soins médicaux à fournir aux participants à la recherche, pendant et après son déroulement ;
4. Adéquation du contrôle médical et du soutien psychosocial pour les participants à la recherche ;
5. La mise en place des mesures pour protéger les femmes, les hommes et les sous-groupes vulnérables de dommages sociaux ;
6. Ajustement de la posologie en fonction des facteurs physiobiologiques liés aux hommes et aux femmes ;
7. Marche à suivre si les participants se retirent volontairement au cours de la recherche ;
8. Critères pour un accès étendu aux produits testés, leur utilisation en urgence et/ou à titre compassionnel ;
9. Dispositions pratiques, le cas échéant, pour informer le médecin généraliste du participant (médecin de famille), y compris procédures pour recueillir le consentement du participant à la recherche ;

10. Description des plans éventuels pour que le produit testé reste disponible pour les participants après la fin de la recherche ;
11. Description des coûts financiers à la charge des participants à la recherche ;
12. Dédommagements et indemnités des participants (y compris argent, services et/ou cadeaux) ;
13. Dispositions prises pour la compensation/le traitement en cas de préjudices/incapacité/décès d'un participant, imputable à sa participation à la recherche ;
14. Dispositions prises en matière d'assurance et de compensation.

1.4.4. Protection de la confidentialité des données du participant à la recherche

1. Description des personnes qui auront accès aux données personnelles des participants, y compris aux dossiers médicaux et aux échantillons biologiques ;
2. Mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des informations personnelles concernant les participants.

1.4.5. Processus de consentement éclairé

1. Description détaillée du processus d'obtention du consentement éclairé, y compris l'identification des personnes responsables de cette obtention ;
2. Pertinence, exhaustivité et clarté des informations écrites et orales qui seront remises aux participants à la recherche et, le cas échéant, à leur(s) représentant(s) légal (légaux) ;
3. Justification claire de l'intention d'inclure dans la recherche des participants ne pouvant donner leur consentement, et description détaillée des dispositions prises pour obtenir ce dernier ;
4. Assurance que les participants à la recherche recevront les informations qui ne seraient connues que pendant le déroulement de la recherche et ayant trait à leur participation, y compris leurs droits, sécurité et bien-être ;
5. Dispositions prises pour recevoir et répondre aux demandes et plaintes des participants à la recherche ou de leurs représentants pendant sa mise en œuvre.

1.4.6. Considérations communautaires et relatives à la politique de santé du Sénégal

- 1- Impact et pertinence de la recherche sur la communauté locale, sur les communautés d'où proviennent les participants à la recherche et sur les différents besoins des femmes, hommes et des groupes vulnérables de la population ;
- 2- Mesures prises pour consulter les communautés concernées pendant la préparation du projet de recherche ;
- 3- Influence de la communauté sur le consentement des individus ;
- 4- Proposition de consultation de la communauté pendant le déroulement de la recherche ;
- 5- Contribution de la recherche à l'amélioration des capacités telles que le renforcement des réseaux locaux de soins, la recherche, la capacité à répondre aux besoins de santé publique
- 6- Contribution de la recherche à l'égalité entre l'homme, la femme et l'équité en santé.
- 7- Description de la disponibilité et de l'accessibilité financière, pour les communautés concernées, à tout produit expérimental performant, après la recherche ;
- 8- Méthodes par lesquelles les résultats de la recherche seront rendus disponibles pour les participants à la recherche et les communautés concernées.

1.4.7. Suivi après avis favorable du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé

Après émission d’un avis favorable, un avis réglementaire (pour les essais utilisant un médicament ou autre dispositif médical) et une autorisation administrative, le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé doit identifier une équipe, qui, en rapport avec le SP suit l’évolution dudit protocole.

Le CNERES est tenu d’ouvrir un dossier spécifique et le tenir à jour pour un suivi strict du projet de recherche dans le respect des BPC/ICH/E6.

1.5. CE-5- Canevas d’évaluation et de management des essais cliniques

1.5.1. Préalables :

1.5.1.1. Définition d’un essai clinique (Guide de l’OMS sur les BPC/ICH/E6)

Un essai clinique se définit comme une étude systématique d’un médicament chez l’homme pour découvrir ou vérifier ses effets et / ou identifier des effets secondaires dans le but de s’assurer de sa sécurité et de son efficacité avant sa mise à disposition pour les utilisateurs.

1.5.1.2. Qu’est ce qui constitue un essai clinique ?

- Un ou plusieurs médicaments ;
- Des patients ;
- Des médecins et des équipes soignantes ;
- Des sites médico-techniques (ex : laboratoire) ;
- Un promoteur ;
- Un ou des méthodologistes et statisticiens.

1.5.1.3. Qui contrôle et surveille un essai clinique ?

- Le Comité National d’Ethique pour la recherche en Santé ;
- L’autorité de santé constitué par le Ministre chargé de la santé et de l’action sociale représenté dans ce dispositif par la DPRS et la DPM ;
- Le Promoteur ;
- Le comité de surveillance des données de tolérance (CSDT/DSMB);
- Le moniteur externe (CRO) ;
- Un Comité de suivi mis en place par ministre chargé de la santé et de l’action sociale.

1.5.1.4. Evaluation de la mise en œuvre d’un essai clinique

- Comment évaluer ? Avec la grille d’analyse à partir des critères définis par les BPC/ICH/E6 ;
- Qui évalue ? Le promoteur, le CNERES et la DPM ;
- Quoi évaluer ? Le produit, les participants, les procédures (SOP), le respect des principes éthiques, la pharmacovigilance, la compétence de l’équipe de recherche, la conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays ;
- Quand évaluer ? Pendant et à la fin de l’essai.

1.5.2. Eléments de revue d'un protocole d'essai clinique

1.5.2.1. *Revue des objectifs de l'essai*

- L'intérêt de l'essai pour la population qui y participera ;
- L'intérêt de l'essai en termes de résultats attendus de l'essai ;
- Les risques liés à l'essai ;
- La faisabilité de l'essai ;

L'accent est mis sur la détection des points critiques, au besoin faire appel à une expertise externe. L'évaluation d'un essai clinique consiste à étudier principalement 4 axes majeurs :

- Le respect des règles éthiques ;
- La sécurité des participants ;
- La validité scientifique et médicale de l'essai ;
- La validité méthodologique et l'absence de biais de l'essai ;
- La faisabilité de l'essai.

1.5.2.2. *Respect des règles éthiques des participant(e)s*

Les membres du CNERS se poseront les questions suivantes :

- Le projet a-t-il été évalué par un autre comité d'éthique ?
- Comment sont prévus l'information du participant et le recueil de son consentement ?
- Comment seront garanties la confidentialité et la protection des données ?

1.5.2.3. *La sécurité*

A ce niveau d'évaluation, les membres du CNERS se poseront les questions suivantes :

- ☛ Le patient qui va participer à l'essai va-t-il avoir entre autres :
 - Un bénéfice thérapeutique ?
 - Une perte de chance ?
 - Une expérience de préjudice social due à la participation à la recherche ?

Pour répondre à ces questions, les membres du CNERS évalueront :

- ☛ Si les produits à l'essai présentent des garanties de sécurité :
 - La conception et la qualité pharmaceutique des produits sont-elles adéquates ?
 - Les prérequis non cliniques sont-ils satisfaisants ?
 - L'efficacité des produits a-t-elle été démontrée ?
 - A-t-on une bonne connaissance des effets prévisibles des produits ?
- ☛ Si la balance avantages / risques est en faveur d'un bénéfice pour le/la participant
 - Ce qui est prévu pour le suivi de la tolérance en cours d'essai ;
 - Ce qui est prévu pour la prise en charge des participants pendant et après l'essai ;
 - Ce qui est prévu pour la protection des participants contre les préjudices sociaux pouvant résulter de leur participation à l'essai clinique.

1.5.2.4. Validité scientifique et médicale de l'essai

Les membres du CNERS se poseront les questions suivantes :

- Les résultats de l'essai seront-ils utilisables ?
- Les participants de l'essai sont-ils semblables à la population exposée ?
- Le traitement des participants et leur suivi est-il celui adapté dans le contexte ?

Pour répondre à ces questions, les membres du CNERS évalueront :

- Si les critères d'inclusion et de non inclusion sont appropriés au regard de la population cible ;
- Si les modalités de traitement des participants sont adaptées ;
- Si la fréquence et les modalités de suivi sont adaptées ;
- Si les critères d'efficacité sont justifiés ;
- Si le recueil des événements indésirables est adapté ;
- Si des stratégies posologiques spécifiques étaient envisagées pour prévenir des événements indésirables chez les femmes et / ou les hommes.

1.5.2.5. Validité méthodologique et absence de biais

Les membres du CNERS se poseront les questions suivantes :

- Les résultats de l'essai seront-ils justes ?
- L'efficacité sera-t-elle réelle ?
- La tolérance ne sera-t-elle pas sous-estimée ?

Pour répondre à ces questions, les membres du CNERS évalueront :

- Si la méthode choisie (essai randomisé ou non randomisé) est adaptée à la question posée ;
- Si le calcul du nombre de participants à inclure est justifié et prend en compte la variabilité de mesure du critère de jugement principal ainsi que les sorties de l'essai ;
- Si la différenciation entre les participants a été prise en compte pendant le calcul de la taille de l'échantillon ;
- Si la méthode de randomisation est adaptée et utilisable ;
- Si les critères de sortie d'essai sont précis, utilisables, justifiés et vérifiables ;
- Si la stratégie d'analyse statistique est décrite.

1.5.2.6. Faisabilité de l'essai

Les membres du CNERS se poseront la question suivante :

- L'essai est-il possible dans les conditions prévues par le protocole ?

Pour répondre à ces questions, les membres du CNERS évalueront :

- Les conditions de recrutement, de soins et de suivi des participants ;
- Les conditions de gestion des produits ;
- Les conditions de gestion des échantillons biologiques ;
- Le type, le nombre, la fréquence des examens de laboratoires nécessaires et les conditions dans lesquels ils seront réalisés ;
- Les techniques d'évaluation disponibles et leur validité ;
- Les processus de recueil et de traitement des données ;
- Les conditions prévues de suivi de l'essai et de contrôle de la qualité.

1.5.3. Pré requis d'une étude clinique au sein d'une population :

1.5.3.1. *Pertinence scientifique, médicale, sociale*

- Problème de santé publique reconnu ;
- Rationnel scientifique élaboré sur le produit ;
- Bonnes tolérances envisagées ;
- Formulation applicable à la phase 1 ;
- Des études précliniques ont démontré une pharmacodynamique à une dose appropriée et par une voie appropriée avec un challenge si possible dans le cas de vaccins) ;

1.5.3.2. *La pathologie : ses moyens diagnostics et sa prise en charge thérapeutique.*

1.5.3.3. *Epidémiologie :*

- Incidence et prévalence
- % de personnes infectées développant la maladie
- Risque de transmission
- Caractéristiques socio démographiques
- Saisonnalité.

1.6. CE6- Evaluation éthique simplifiée

1.6.1. Situations pouvant faire appel à une évaluation éthique simplifiée

Le CNERS peut recourir dans trois situations à la procédure d'évaluation éthique simplifiée :

- Lorsqu'un projet de recherche se situe sous le seuil du risque minimal pour les sujets qui s'y porteront volontaires ;
- Lorsque le chercheur propose une modification mineure à un projet de recherche que le CNERS a déjà approuvé ;
- Lors de la réévaluation annuelle d'un projet déjà en cours.

La procédure d'évaluation simplifiée n'est pas applicable à l'évaluation éthique initiale des projets de recherche visant des personnes inaptes ou des mineurs

1.6.2. Critères d'identification de recherche à risque minimal

L'évaluation de projet à risque minimal vise les recherches qui impliquent des risques minimaux au bien-être ou aux droits du participant de recherche. De plus, ces projets ne doivent pas se retrouver dans la liste d'exclusion élaborée ci-dessous. Les projets à risque minimal doivent être conformes aux normes reliées aux questions de consentement éclairé, de confidentialité, de l'équilibre entre les risques et les bénéfices, etc.

Le terme « risque » est pris dans un sens large afin d'inclure, entre autres, les risques physiques, psychologiques, économiques et sociaux.

Les risques pour les personnes autres que les participants d'étude peuvent être considérés afin de déterminer si une demande d'évaluation déontologique peut être traitée par l'évaluation de projet à risque minimal.

Les critères d'une étude comportant un risque minimal sont les suivants :

- La probabilité et le degré de risques possibles découlant de la recherche ne dépassent pas ceux rencontrés par les participants dans leur vie de tous les jours et ceci aussi bien au niveau physique, émotionnel, psychologique, légal, social ou économique ;
- La recherche ne comporte pas de procédures invasives ;
- La recherche ne comporte pas de risque de coercition (relation de hiérarchie comme des employés, des étudiants, du personnel militaire, relation de tutorat, des populations captives comme les détenus) ;
- La recherche n'implique pas des populations vulnérables comme des enfants, des personnes avec déficience cognitive ou mentale, des femmes enceintes, professionnelles de sexe, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des individus inaptes à donner leur consentement, des personnes faisant l'objet de discrimination ;
- La recherche n'implique pas des domaines d'études sensibles pour les participants par exemple leurs antécédents ou comportements sexuels ou délictuels, ou politiques, leur expérience de la violence, des abus ou exploitation, leur santé mentale, leur origine ethnique, leur religion ;
- La recherche correspond à une recherche non-interventionnelle définie comme suit :
 - o Actes ou produits utilisés de façon habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
 - o La stratégie médicale destinée à une personne n'est pas fixée à l'avance par un protocole, et relève de la pratique courante.
- L'étude correspond à une recherche sur les soins courants (validés par un consensus professionnel) définie comme suit :
 - o Visant à évaluer les soins courants, autre que le médicament ;
 - o Lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de façon habituelle ;
 - o Eventuellement avec des modalités particulières de surveillance qui pourrait comporter des contraintes supplémentaires, mais négligeables.
- La recherche consiste en une comparaison d'interventions normales en particulier les recherches dont l'objectif est d'évaluer des actes, des combinaisons d'actes ou des stratégies, de prévention, de diagnostic ou de traitement dans le respect de leurs indications.

NB sont exclues de ce champ :

- o Techniques ou stratégies innovantes ou obsolètes ;
- o Combinaisons innovantes d'actes ou de produits même si leur utilisation séparée est courante ;
- o Comparaison de stratégies médicales, si une stratégie peut être considérée comme supérieure, en termes d'efficacité ou de sécurité.
- La recherche occasionne la prise d'échantillons sanguins supplémentaires au moment du prélèvement sanguin indiqué par la clinique. La quantité permise sera déterminée en fonction de l'âge, du poids et de la santé des participants.

- La recherche n'occasionne aucun contact direct avec le/la participant, par contre, elle peut nécessiter l'utilisation de rejet ou les restes de tissus, de sang, d'urine, d'excréments, etc. et seules les données globales sont signalées. Exceptions : Les études comportant des tissus fœtaux rejetés ou du matériel génétique doivent être soumises à l'évaluation du Comité.
- La recherche utilise une collection biologique existante déclarée, réalisée lors de projets de recherche approuvés par le CNERS et sans changement de finalité concernant la thématique desdits projets.
- L'étude comporte uniquement des activités d'assurance de la qualité.
- La recherche consiste en l'utilisation secondaire des données qui ne peuvent être rattachées à un individu.
- La recherche est la duplication d'une étude déjà approuvée et où les changements proposés n'introduisent pas de nouveaux éléments de risque ou ne soulèvent pas de questions éthiques

Evaluation éthique complète

L'évaluation complète s'applique à tous les projets de recherche avec des participants qui ne répondent pas aux critères de l'évaluation éthique accélérée. Elle s'applique aussi, d'emblée, si le projet d'étude vise des mineurs ou des personnes inaptes.

1.6.3. Procédure d'évaluation simplifiée

1.6.3.1. Procédures de dépôt pour une évaluation accélérée

Toute personne qui soumet un projet pour l'obtention de son certificat d'éthique par la voie accélérée doit déposer au secrétariat du CNERS les documents suivants :

- Le formulaire approprié dûment complété et signé par le/la chercheur principal, accompagné des documents qui y sont mentionnés ;
- Le cas échéant, les pages modifiées du projet déjà soumis au CNERS ;
- Le cas échéant, le nouveau formulaire de consentement ou celui modifié (ce document doit spécifiquement indiquer tous les changements apportés à la version que le CNERS a déjà approuvée);
- Si applicable, le protocole de recherche et les documents destinés à être remis aux participants de recherche ;
- Tout autre document jugé pertinent par le chercheur.

1.6.3.2. Procédures d'évaluation

La procédure d'évaluation du CNERS est effectuée par deux examinateurs, c'est-à-dire le président et un autre membre du CNERS (qui peut être choisi en fonction de ses compétences). Après que l'approbation de l'évaluation accélérée a été accordée, un résumé de l'information (titre de la recherche, nom des chercheurs et toute autre information jugée pertinente) de la proposition sera soumis au CNERS aux fins de ratification.

Les membres du CNERS peuvent demander une copie du protocole complet et peuvent exiger que la ratification soit retardée jusqu'à la prochaine réunion du CNERS. Dans le cas où l'étude n'est pas approuvée par tous les membres du Comité, elle sera interrompue jusqu'au moment où toutes les questions auront été réglées et que l'approbation sera accordée par tous (ou une majorité) les membres du CNERS.

1.6.3.3. Cheminement et délai de l'évaluation éthique par voie accélérée

Si, à la suite de son évaluation préliminaire du projet de recherche, le secrétariat permanent à l'éthique de la recherche juge que le protocole répond à l'une des conditions de l'article 20 de la présente procédure, il peut l'acheminer au président du CNERS qui procédera, avec au moins un autre membre, à l'évaluation du projet dans un délai approximatif de deux (2) semaines à partir de la date de sa réception.

1.6.3.4. Décision

Le sous-comité du CNERS qui procède à l'évaluation d'un projet par voie accélérée peut accepter ou refuser d'émettre un avis éthique. Le sous-comité peut également demander que ledit projet soit modifié afin de répondre aux normes éthiques en vigueur.

La décision du sous-comité est prise au nom du CNERS

1.6.3.5. Transmission de la décision du CNERS

Toute décision prise en vertu du mode d'évaluation éthique accélérée doit être communiquée dans les plus brefs délais à l'ensemble des membres du CNERS et ce, afin que le CNERS puisse continuer à contrôler les décisions prises en son nom.

1.7. CE7- Guide de rédaction d'un avis du CNERS

1.7.1. Introduction

A la suite de l'évaluation scientifique et éthique du projet de recherche, le CNERS émet un avis qui est communiqué par écrit au chercheur, autant que possible dans les trois semaines suivant la date de la réunion au cours de laquelle le projet a été examiné.

L'examen du projet de recherche peut donner lieu à différentes issues :

- Avis favorable ;
- Report de l'avis jusqu'à réception des réponses aux commentaires/questions et après que les membres aient transmis leur avis sur ces réponses dans un délai raisonnable (maximum une semaine). Ne nécessite pas un réexamen en session ;
- Report de l'avis jusqu'à après examen des modifications apportées par le chercheur et tenant compte des observations du CNERS. Nécessite un réexamen du protocole lors d'une session plénière ;
- Avis défavorable.

Le CNERS peut dans la lettre adressée au chercheur formuler des recommandations et des suggestions.

Dans ses commentaires et avis, le CNERS doit faire une lecture des dimensions éthiques en présence et faire état des problèmes potentiels via l'anticipation des répercussions (positives ou négatives) sociales et sanitaires sur les individus et les collectivités.

Ainsi, dans le cas d'un avis défavorable, la lettre adressée aux chercheurs doit exposer les raisons qui justifient ces avis.

1.7.2. Contenu de l'avis

La communication de la décision comporte notamment les éléments suivants :

- Titre du projet de recherche examiné ;
- Identification claire du projet de recherche en utilisant le numéro d'enregistrement au niveau du secrétariat du CNERS, du projet (ne pas oublier de citer le numéro du projet antérieurement approuvé en cas d'amendement et donner des numéros aux amendements) ;
- Date et numéro de version du projet validé ;
- Nom et numéro d'identification des documents examinés, comprenant la note d'information et le formulaire de consentement du participant éventuel ;
- Nom et qualité du chercheur ;
- Désignation du ou des sites de recherche ;
- Lieu et date de l'avis ;
- Description claire de la décision prise.

En cas d'avis différé, énoncer avec précision les questions posées par le CNERS, les suggestions de révision les procédures de réexamen de la demande, et les conseils éventuellement donnés par le CNERS.

En cas de décision favorable, énoncer les responsabilités du demandeur, par exemple :

- engagement au respect strict des conditions de mises en œuvre figurant dans le protocole,
- confirmation de l'acceptation des exigences du CNERS,
- remise de rapports d'évolution de la recherche,
- nécessité de soumettre tout amendement au protocole,
- nécessité de rapporter les événements indésirables graves et/ou inattendus liés à la conduite de la recherche,
- nécessité de rapporter les circonstances imprévues, la clôture ou la suspension de la recherche ou les décisions significatives prises par d'autres Comités d'éthique de la Recherche dans le cas d'études multicentriques,
- nécessité de produire et transmettre au CNERS un rapport final ;

En cas de décision défavorable, motiver la décision en énonçant clairement les motifs et explicatifs ;

- Signature datée du président du CNERS ou d'une autre personne autorisée.

1.7.3. Structuration de l'avis

Le : (date)

Fonction de la personne qui rédige la lettre au nom du CNERS (SP /Président ?)

A : Identification du demandeur : (Nom, adresse, ...)

Identification du protocole : numéro attribué à cette demande par le secrétariat permanent du CNERS (SEN 0X/0Y). N° de version et date du protocole

Titre du projet auquel la demande est rattachée

Désignation des sites où se déroule le projet en titre

Madame,
Monsieur,

Première partie : Description des documents examinés

Le Comité National d'éthique de la Recherche pour la Santé (CNERS) dans sa session du [date] a examiné le protocole ci-dessus visé

À cette fin, les documents suivants ont été examinés :
[Les nommer en précisant le numéro et la date de leur version]

Deuxième partie : selon la nature de la décision rendue

○ Approbation de la demande telle quelle

Il me fait plaisir de vous informer que votre demande [projet, présentation d'une proposition de modification, demande de renouvellement d'approbation] a été approuvée,
Cette approbation suppose que vous vous engagiez :

- A respecter la présente décision ;
- A conserver les dossiers de recherche pour une période d'au moins deux ans suivant la fin du projet afin de permettre leur éventuelle vérification par une instance déléguée par le comité ;
- (En cas d'essai vaccinal) : A conserver les échantillons biologiques liés au projet durant une durée de X années ;
- A fournir tous les ans un rapport d'évolution du projet ;
- A soumettre au CNERS pour approbation tout amendement aux protocoles autres que les amendements ne concernant que les aspects administratifs ou logistiques de la recherche ;
- A transmettre au CNERS de tout nouveau renseignement susceptible de modifier le rapport bénéfice/risque de la recherche ;
- A rapporter les événements indésirables graves et inattendus liés à la conduite de la recherche ;
- A informer le CNERS en cas de cessation prématurée du projet, de suspension du projet ou de circonstances imprévues et de toute décision significative concernant le projet ;
- A informer le CNERS en cas de problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du projet ;
- A informer le CNERS de tout problème constaté par un tiers lors d'activité de vérification (audit externe, comité de surveillance de données de sécurité, audit d'autorités de réglementation, etc.)

La présente décision vaut pour une année et peut être suspendue ou révoquée en cas de non-respect de ces exigences. La prolongation de l'approbation est conditionnée par le dépôt d'un rapport d'évolution du projet

- **Demande de précisions ou de modifications**

Le CNERS n'a pas été en mesure d'approuver votre demande telle qu'elle a été présentée et souhaiterait avoir des précisions (ou des renseignements complémentaires) avant de pouvoir statuer définitivement sur cette demande.

OU le CNERS vous demande d'apporter les modifications suivantes, ...

[Indiquez les précisions ou les renseignements complémentaires ou les modifications demandés et les motifs qui les justifient]

Votre projet sera réévalué par les membres du CNERS à la lumière des réponses et précisions que vous aurez apportées lors de la prochaine réunion du comité.

A cette fin, les documents explicatifs doivent être transmis au comité au plus tard quinze (15) jours avant la tenue de la réunion.

OU vos réponses et les modifications apportées à votre projet feront l'objet d'une évaluation éthique simplifiée.

- **Non approbation**

Après avoir réévalué votre demande, le CNERS n'a pu l'approuver pour les motifs suivants :

[Indiquez les motifs et leur fondement]

Il vous est possible de demander une réévaluation de la présente décision si des changements intervenaient.

Troisième partie

Je vous demanderais de bien vouloir mentionner dans vos correspondances ultérieures le numéro attribué à votre demande par le secrétariat du CNERS.

Quatrième partie

[Formule de politesse]

Signature :

Président du CNERS / SP Secrétariat permanent

NB : Lors de demande d'informations complémentaires, les membres du comité statueront suivant l'importance du sujet, sur la nécessité ou non de réexaminer les modifications apportées ou les réponses, lors d'une session plénière.

1.8. CE8- Respect de la confidentialité par les experts externes au CNERS

Conformément aux dispositions du décret n° 2009-729 portant **création, organisation et fonctionnement du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS)** (articles 5 et 18) et aux articles du règlement intérieur du CNERS relatifs aux experts externes, des experts extérieurs au CNERS peuvent être désignés selon les spécificités des protocoles de recherche soumis, et le CNERS peut solliciter l'avis d'un expert sur tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts susceptibles d'apporter un éclairage scientifique et technique pourront prendre part aux réunions du CNERS, mais ne participent pas aux prises de décision.

Ces experts signent un formulaire d'engagement du type suivant : « Je soussigné, Mme ou M. xxxxxxxx, titre et fonction, donne mon accord pour évaluer le protocole intitulé

« », sous forme écrite ou éventuellement par une participation à la réunion du CNERS chargé de donner son avis.

Je reconnais que je ne me trouve dans aucune situation de conflit d'intérêt par rapport aux investigateurs et au promoteur de la recherche que j'accepte d'examiner.

Le CNERS s'engage à respecter la confidentialité de l'avis que je lui communiquerai sous forme écrite, ou, le cas échéant, sous forme orale lors d'une session du CNERS.

Je m'engage à respecter la confidentialité absolue quant au contenu du protocole examiné et à ne divulguer aucune information dont j'aurai à connaître dans le cadre de l'expertise, en particulier lors d'une session du CNERS ou au cours d'échange avec le CNERS.

Date.....

Signature :

1.9. CE9- Procédures de communication

Les membres du CNERS de même que les membres du secrétariat permanent sont tenus au respect de la confidentialité concernant les protocoles examinés ainsi que les délibérations conformément au serment prêté.

La communication sur les dossiers gérés au niveau du CNERS est ainsi organisée :

Le SP est chargé de veiller à la gestion confidentielle des documents enregistrés au niveau du CNERS. Il est chargé de servir d'interface entre les chercheurs, sponsors et autres acteurs du système de recherche et les membres du CNERS pour ce qui concerne la communication.

La voie électronique, le format papier et le téléphone peuvent être utilisés par le SP pour communiquer avec les membres du CNERS sur tous les dossiers relatifs au domaine de compétence du CNERS.

La voie électronique est recommandée pour toute communication importante et/ou urgente sur un protocole afin que les échanges puissent être partagés avec tous les membres.

Pour les réunions, les invitations sont envoyées sous format électronique dix (10) jours au moins avant la réunion.

Pour toute observation sur un protocole, les membres du CNERS qui ne peuvent être présents lors de la session d'examen, peuvent envoyer par écrit leurs contributions.

Les procès-verbaux des réunions d'évaluation des protocoles sont validés via internet.

Ces procès-verbaux sont envoyés aux membres ayant participé à l'évaluation y compris ceux qui ont envoyé leurs observations écrites.

Lorsqu'un membre du CNERS est partie prenante d'un protocole, il lui est adressé de manière séparée, un procès-verbal ne comportant pas la partie le concernant.

Une fois le procès-verbal validé, le SP est chargé de communiquer à chaque chercheur les résultats des délibérations concernant son protocole.

Les réponses données par les chercheurs doivent être envoyées sous format électronique au SP qui doit les répercuter aux membres du CNERS qui ont statué sur le protocole. Une fois les réponses validées par ces derniers, le SP peut émettre l'avis éthique qui est envoyé au chercheur sous format électronique et/ou papier.

Pour les essais vaccinaux, les réponses devront être discutées par l'ensemble des membres et l'avis définitif être systématiquement soumis au prochain comité avant sa transmission au chercheur.

1.10. CE10- Suivi des essais cliniques

Le CNERS, dans le cadre de sa mission de protection des participants à la recherche, effectue des visites de suivi en vue de vérifier que la mise en œuvre est en conformité avec le contenu du protocole de recherche validé et de s'assurer du respect des principes éthiques.

L'équipe de suivi du CNERS est composée de membres bien formés aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux Bonnes Pratiques de la Recherche (BPR).

Les éléments suivants sont entre autres vérifiés lors des visites de terrain :

- Vérifier les progrès de l'essai clinique pour assurer que le protocole d'étude est suivi et est en conformité avec les BPC et les BPR ;
- Vérifier l'inscription des sujets qualifiés ;
- Vérifier la cohérence de la collecte de données et du traitement des patients sur plusieurs sites afin de détecter les déviations de communication / d'adressage avec le protocole d'essai clinique, des modes opératoires normalisés, BPC, etc. ;
- Examen des documents afin de vérifier que les rapports, demandes et autres documents sont exacts et à jour ;
- Veiller à ce que les effets indésirables soient présentés conformément aux BPC, au protocole, aux comités d'éthique et aux autorités réglementaires ;
- Vérifier la gestion opérationnelle des effets indésirables survenus et, entre autres, les références faites ;
- Vérifier l'effectivité de la préparation de rapports des résultats cliniques de surveillance après visite des sites selon des modes opératoires normalisés (SOP) établis ;
- Vérifier l'effectivité de l'établissement d'un rapport final d'étude clinique et la compilation du dossier d'étude ;
- Vérifier la conformité des procédés de recueil du consentement ;
- Discuter avec certains participants pour vérifier la qualité des consentements ;
- Vérifier l'inscription des personnels médicaux dans les différents ordres du pays ;
- Vérifier les banques de données mises en place (conformité des contenants réfrigérés aux standards de conservation des produits pharmaceutiques et autres matériels biologiques) ;
- Vérifier le dispositif de gestion des déchets biomédicaux.

1.11. CE11- Gestion des déclarations d'EIG

Le rapport sur les événements indésirables graves est enregistré dans le dossier ouvert sur le protocole de recherche. En rapport avec les services concernés du ministère qui ont aussi reçu le document. Le CNERS veille à l'application des engagements déjà validés lors de l'examen du protocole.

En relation avec le sponsor, le principal investigateur et le ou les participants à l'étude, le CNERS suit la mise en œuvre du processus de gestion de l'événement jusqu'à terme et veille à la préservation des intérêts du ou des participants concernés.

Au terme du processus de gestion de l'EIG, le PI est tenu de transmettre au CNERS un rapport d'achèvement qui sera par la suite versé dans le dossier ouvert à cet effet.

1.12. CE12- Gestion des amendements

Le dossier d'amendement élaboré conformément à la procédure CH5 de la brochure destinée aux chercheurs, est enregistré au CNERS sous un numéro en lien avec le protocole de base.

Cet amendement s'il est majeur est programmé à la prochaine session du CNERS pour faire l'objet d'évaluation. Le secrétariat prend ainsi toutes les dispositions pour rendre disponibles les minutes du procès-verbal du CNERS relatives audit protocole, les réponses qui étaient données, l'avis et le protocole de base.

Les membres du CNERS statuent sur l'amendement proposé. La décision prise à ce sujet par les membres du CNERS sera transmise au chercheur par le SP suivant la procédure décrite en CE7.

Si l'amendement est considéré comme mineur, il est toujours enregistré dans les mêmes conditions et l'information devra être donnée via internet à l'ensemble des membres du comité qui ont siégé sur ce protocole.

1.13. CE13- Canevas de rédaction du rapport annuel

Conformément au décret n° 2009-729, le CNERS est tenu de produire un rapport d'activités chaque année. Ce rapport est rédigé suivant le canevas ci-après

1.13.1.1. Introduction

Dans cette partie, le SP du CNERS rappelle les missions et le contexte de fonctionnement du comité. Il présente les axes majeurs de travail du comité et les points sur lesquels le rapport va mettre l'accent. Les moyens disponibles pour mener les activités du CNERS

1.13.1.2. Développement

- Nombre de protocoles reçus,
- Nombre de protocoles examinés,
- Nombre de protocoles validés,
- Nombre de protocoles rejetés,
- Nombre de réunions d'évaluation de protocoles tenues,
- Domaines couverts par les protocoles reçus avec les tendances,
- Nombre de protocoles suivis
- Autres activités menées (réunions thématiques, formation, etc.),
- Partenariats (conférence, ateliers, formation en ligne, projets auxquels le CNERS est impliqués etc.),
- Questions éthiques majeures abordées lors de l'examen des protocoles
- Ressources reçues et dépenses effectuées.

1.13.1.3. Conclusion

Les difficultés rencontrées, les leçons apprises, les prochaines étapes et perspectives

1.14. CE14- Procédure de documentation et d'archivage

Toutes les documentations et correspondances du CNERS doivent être datées et archivées selon des procédures écrites.

Les documents à classer et à archiver sont notamment :

1. La composition, les procédures opératoires standard du CNERS, les procès-verbaux, les protocoles validés et toutes les correspondances y afférant, les fiches synoptiques des protocoles examinés, les feuilles de présence aux réunions, les rapports d'experts, les rapports de suivi et les rapports réguliers (annuels) ;
2. Le curriculum vitae de tous les membres du CNERS ;
3. Toutes les recettes et dépenses du CNERS, y compris indemnités et remboursements
4. Copie électronique de tous les documents déposés par un demandeur ;
5. Correspondance des membres du CNERS avec les demandeurs ou les parties concernées par la demande, la décision et le suivi ;
6. Toute la documentation écrite reçue pendant le suivi ;
7. Notification de la clôture normale, de la suspension ou de l'arrêt prématuré d'une recherche ;
8. Résumé final ou rapport final de la recherche.

Entre autres, les protocoles déposés au secrétariat du CNERS doivent être enregistrés sous un numéro d'identification unique qui sera mentionné dans tous les documents et correspondances relatifs au protocole.

Il est demandé aux chercheurs de faire mention de ce numéro dans toutes les correspondances adressées au CNERS à ce sujet.

Les amendements d'un protocole doivent être enregistrés sous le même numéro d'identification auquel sera rajoutée une indication identifiant un amendement (Ex A1).

Un document définissant l'accès et la procédure de consultation des différents documents, fichiers et archives est élaboré et diffusé (avec les noms des personnes autorisées).

1.15. CE15- Frais de soumission des protocoles.

1.15.1. Rappel des dispositions financières énoncées dans le décret 2009-729 portant création du CNERS

Article 24. Les ressources du CNERS proviennent du budget de l'État, des frais de soumission des protocoles fixés par le CNERS et des appuis des partenaires au développement.

Les ressources du CNERS sont dépensées selon les rubriques ci-après :

- Suivi et évaluation sur le terrain des protocoles de recherche mis en œuvre ;
- Prise en charge par les membres du CNERS lors des réunions d'examen de protocole ;
- Achat de fournitures et d'équipement de bureau ;
- Soutien logistique ;
- Indemnités mensuelles de motivation de l'équipe de secrétariat.

Ainsi qu'inscrit dans le décret n° 2009-729, les ressources provenant des frais de soumission participent au budget de fonctionnement du CNERS. Le montant des frais de financement est fixé par le CNERS.

1.15.2. Etude préalable des pratiques concernant les montants de frais de soumission

La fixation des frais de soumission a été précédée d'une étude sur la pratique en matière de frais de soumission au niveau international.

Différentes approches existent :

- Un seul tarif quel que soit le type de recherche et le sponsor ;
- Un tarif variable selon le type de recherche ;
- Un tarif variable selon la qualité de l'instigateur de la recherche ;
- Un tarif selon le sponsor/bailleur de la recherche ;
- Un tarif selon le montant de la recherche.

Les montants des frais, très variables d'un pays à l'autre, vont de 1 à 2 500.000 CFA pour les études provenant de l'industrie pharmaceutique à quelques centaines de milliers de francs CFA.

Dans certains pays, des frais de soumission sont exigibles pour le renouvellement annuel de l'approbation et/ou pour les demandes d'amendement.

Dans d'autres pays, le budget des comités en charge de l'évaluation des projets de recherche étant entièrement pris en charge par les autorités publiques, les protocoles de recherche sont exemptés de frais de soumission.

1.15.3. Fixation des frais de soumission par le CNERS

Suite au rapport d'étude sur le montant des frais le CNERS a décidé de fixer un montant de frais de soumission prenant en compte différents paramètres :

- Le type de promoteur : structure à but commercial, structure à but non lucratif, structure académique ;
- Le type d'études suivant le niveau de risque ou de complexité avec comme corollaire la nécessité d'appels à une expertise extérieure nationale ou internationale, la nécessité d'un suivi sur le terrain tout au long de l'étude, d'évaluation des amendements ;
- Le montant du projet de recherche.

Une pondération a été réalisée en vue d'une répartition équitable des charges permettant de ne pas entraver les recherches à faible budget ou provenant de structures à vocation de formation et de recherche tout en permettant un fonctionnement régulier et optimal du CNERS (dont dépend l'attribution de financements par certains bailleurs internationaux).

Le CNERS, conscient de la possible tentation de sous-estimation des projets en vue d'une minimisation des frais de soumission, évaluera la cohérence des budgets proposés par rapport à la faisabilité du projet et se réserve la possibilité de procéder à des vérifications.

Le montant des frais tels que fixés par le CNERS figure à l'annexe 2 du présent document.

Le secrétariat, selon les critères exposés dans ledit document, vérifiera avec le chercheur la catégorie dans laquelle est classée le projet déterminant ainsi le montant exigible (NB : le chercheur aura par ailleurs évalué par lui-même la catégorie dans laquelle se place le projet qu'il présente).

Lors de l'examen, le CNERS peut décider de reclasser le protocole s'il s'avère que des informations incomplètes ou erronées ont entraîné un classement dans une catégorie déterminant un montant inférieur ou supérieur. Dans l'un ou l'autre cas, il sera demandé soit

au chercheur de compléter le montant des frais avant le rendu des résultats de l'examen du protocole soit à la comptabilité du CNERS de rembourser le trop-perçu.

Les chercheurs qui estiment que leur projet entre dans les critères d'évaluation simplifiée (voir procédure correspondante) peuvent le soumettre dans cette catégorie en fournissant les différents éléments d'appréciation. Il est cependant à noter que si après évaluation par les membres du CNERS en charge de la procédure, il s'avère que le projet ne remplit pas les critères d'un projet éligible à l'évaluation simplifiée, le chercheur devra reprendre la procédure de soumission classique et verser le montant des frais correspondant qui viennent en addition du montant versé pour l'évaluation simplifiée.

1.15.4. Gestion des montants versés

Les frais de soumission sont versés dans un compte du CNERS administré selon les règles de la comptabilité publique. Les dépenses sont celles prévues à l'article 24 du décret n° 2009-729.

II. Procédures de fonctionnement du Secrétariat du CNERS

Introduction

Cette brochure est élaborée pour permettre aux membres du secrétariat permanent du CNERS d'assurer une administration de qualité des protocoles de recherche et de tout dossier entrant dans le cadre de l'évaluation et du suivi des activités qui leur sont rattachés.

Les membres du secrétariat permanent du CNERS suivant l'organigramme défini dans le décret n° 2009 729 portant organisation et fonctionnement du CNERS, sont appelés à recevoir les protocoles, à fournir les informations de base aux chercheurs et autres acteurs de la recherche, à assurer la préparation matérielle des activités du CNERS (réunion, séminaire, mission de suivi, d'inspection, acheminement des différentes correspondances, appui aux différents membres du CNERS et aux experts agréés appelés à faire un travail spécifique pour le comité, etc.). Les membres du secrétariat permanent au même titre que les membres du CNERS sont tenus au devoir de réserve et de confidentialité pour toute information du comité qualifiée de non publique.

Pour mener à bien ce travail, les membres du secrétariat permanent ont besoin de référentiels qui leur permettent d'objectiver les actes accomplis. Ce document est ainsi élaboré à cette fin.

2.1. SEC1- Document décrivant la procédure de réception d'un protocole de recherche

2.1.1. Soumission

Une demande d'évaluation éthique d'un projet de recherche impliquant des sujets humains doit être déposée par un chercheur qualifié, responsable de la conduite éthique et scientifique de la recherche.

2.1.2. Exigences relatives à une demande d'examen

Les exigences pour la soumission d'un projet de recherche sont clairement décrites dans la fiche de recevabilité (SEC2). Ces exigences doivent inclure les points suivants :

- Nom(s) et adresse(s) du président du CNERS auprès de qui le dossier de demande doit être déposé ;
- Lettre/Formulaire(s) de demande datée et signée par le PI ;
- Format de la demande : le protocole doit être bien présenté ;
- Documentation : fournir toute la documentation estimée nécessaire pour une information juste et complète du CNERS ;
- Protocole de la recherche proposée (clairement identifié et daté) avec documents justificatifs et annexes ;
- Résumé (si possible dans un langage non technique), synopsis ou représentation simplifiée du protocole sous forme de schéma ;
- Description (généralement incluse dans le protocole) des considérations éthiques liées à la recherche ;

- Cahiers d'observation, agendas patients et autres questionnaires destinés aux participants à la recherche ;
- Lorsque la recherche implique un produit à l'étude (tel qu'un médicament ou un appareil médical), un résumé adéquat de toutes les données de tolérance, pharmacologiques, pharmaceutiques et toxicologiques disponibles sur le produit évalué, ainsi qu'un résumé de l'expérience clinique acquise à ce jour avec ce produit (ex : brochure investigateur récente, publications, résumé des caractéristiques du produit) ;
- Curriculum vitæ de (des) l'investigateur(s) (à jour, daté et signé) ;
- Moyens prévus pour le recrutement des participants potentiels à la recherche
- Description de la procédure suivie pour obtenir le consentement des sujets ;
- Note d'information (clairement identifiée et datée) et autres formes d'information destinée aux participants potentiels, dans la (les) langue (s) comprise (s) par eux et, si nécessaire, dans d'autres langues ;
- Formulaire de consentement éclairé (clairement identifié et daté) dans la (les) langue(s) comprise(s) par les participants potentiels et, si nécessaire, dans d'autres langues ;
- Déclaration concernant une éventuelle indemnisation des sujets se prêtant à la recherche, pour leur participation (y compris remboursement des frais et accès à des soins médicaux) ;
- Description des dispositions prises, le cas échéant, pour l'indemnisation en cas de préjudice ;
- Description des dispositions prises, le cas échéant, pour la couverture d'assurance des participants ;
- Déclaration de l'investigateur par laquelle il s'engage à respecter les principes éthiques fixés dans les lignes directrices appropriées ;
- Toutes décisions antérieures significatives (ex : décision défavorable ou demande de modification du protocole) prises par d'autres CE ou autorités réglementaires à propos de la recherche en question (que ce soit dans le même site de recherche ou un autre) et indication du (des) changement(s) apporté(s) au protocole à cet égard. Les raisons des précédentes décisions défavorables doivent être fournies.

Une fois l'ensemble de ces éléments vérifiés et conformes, le secrétariat permanent recueille le protocole selon le type de projet et si applicable, le montant dû des frais de soumission et délivre un reçu de versement.

Un accusé de réception est fourni au chercheur avec mention de la date d'évaluation du protocole.

2.2. SEC2- Procédure d'enregistrement des protocoles et d'accès à la plateforme

Les protocoles et leurs annexes sont déposés en version électronique au niveau de la plateforme du site www.cners.sn. Après vérification des différents éléments déposés sur la plateforme, un numéro d'ordre est automatiquement généré pour le protocole. Ledit numéro est composé des deux derniers chiffres de l'année en cours et du nombre ordinal de l'enregistrement du protocole au niveau de la plateforme, séparés par une barre oblique (ex : SEN11/18 signifie 18e protocole de l'année 2011 planifié à être mené au Sénégal).

Ce numéro du protocole devient désormais l'identifiant à utiliser pour toutes les correspondances relatives à ce dossier et pour le suivi électronique du traitement de la demande.

Pour les membres du CNERS, un compte d'accès est créé par le secrétariat qui donne la possibilité à chaque membre d'accéder aux dossiers programmés pour revue par le secrétariat. Toutefois, le membre doit être préalablement invité pour pouvoir télécharger les protocoles et annexes retenus pour la session. Le membre qui dispose de son adresse électronique peut charger le mot de passe et le mot d'utilisateur qui lui sont attribués.

Pour les chercheurs, ils doivent créer eux même un compte qui leur permet d'accéder à tout moment à la plateforme soit pour y déposer des protocoles soit suivre l'état de traitement de leur demande.

La plateforme est intégrée dans le site du CNERS (www.cners.sn) qui met à la disposition du public des informations sur les activités du CNERS, des documents sur l'éthique et la recherche et toute autre ressource utile à la promotion dudit secteur.

2.3. SEC3- Procédure de gestion des demandes d'amendements

Les amendements sont reçus au niveau de la plateforme et enregistrés sous un numéro lié au protocole de base.

Si c'est un amendement mineur, il est classé au niveau du dossier du protocole de base et ensuite envoyé aux membres du CNERS pour information.

Si l'amendement est majeur, un accusé de réception est donné au principal investigateur avec date de la session d'examen du document par le CNERS. Des frais de soumission sont requis pour l'évaluation de cet amendement.

L'amendement est inscrit dans le tableau synoptique élaboré pour la prochaine réunion.

2.4. SEC4- Document de procédures de gestion des déclarations d'EIG

Dès que le rapport d'EIG est reçu sous format électronique, une copie est imprimée et classée dans le dossier du protocole en question. Toutes les correspondances et les autres rapports relatifs à la gestion de cet EIG sont classés par ordre d'arrivée dans le dossier du protocole.

2.5. SEC5- Procédure d'archivage des documents

Les protocoles reçus sur la plateforme font l'objet d'un archivage automatique. Une fois validée, la version finale est archivée avec tous les documents annexes. Les procès-verbaux, les commentaires, les avis et les autorisations administratives sont archivés sous format électronique. Certains de ces documents sont également disponibles au secrétariat sous format physique..

Pour accéder à ces documents (les commentaires, les avis et les autorisations administratives) les membres doivent passer par le secrétariat.

Les procès-verbaux des réunions de délibération sur les protocoles, les rapports de suivi et ou d'inspection des protocoles font l'objet d'une classification autonome et sécurisée.

2.6. SEC6- Fiche de recevabilité d'un protocole

2.6.1. Fiche de recevabilité d'un protocole de recherche

Titre du projet : sen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.6.2. Conditions à remplir par le(s) demandeur(s)

	Informations générales		Oui	Non
1	Tous les documents sont	• Rédigés/ traduits en français déposés en ligne ;		
2	Dossier déposé dans les limites 20 jours au moins avant la session du comité	Application au niveau de la plateforme de soumission intégrée dans le site du CNER		
3	Paiement des frais d'examen d'une demande	• Vérifier la conformité avec la grille de classification des protocoles selon les niveaux de frais à verser.		

2.6.3. Informations spécifiques

Informations spécifiques							
				Présent		A améliorer	
				Oui	Non	Oui	Non
1	Formulaire de demande adressée au Président du CNERS						
2	Documents fournis par le(s) demandeur(s)						
	1.1 Curriculum vitæ						
	• Du chercheur principal	Un exemplaire	Daté et signé				
	• Des chercheurs associés	Un exemplaire	Daté et signé				
	1.2 Avis d'un comité scientifique agréé		Un exemplaire	Daté et signé			
	1.3 Protocole de recherche incluant						
	2.3.1	Résumé du protocole	Un exemplaire	Datés Cible clairement identifiée			
	2.3.2	Formulaire de consentement libre et éclairé	Un exemplaire				
	2.3.3	Guide d'entretien	Un exemplaire				
	2.3.4	Questionnaire	Un exemplaire				
	2.3.5	Fiche de dépouillement	Un exemplaire				
	2.3.6	Note d'information	Un exemplaire	Questions à transcrire en langue(s) nationales mentionnées			
	2.3.7	Cahiers d'observation	Un exemplaire				
	2.3.8	Agendas patients	Un exemplaire				
	2.3.9	Conditions et modes de recrutement	Un exemplaire				
	2.3.10	Tout autre outil de collecte de données prévu dans le protocole	Un exemplaire				

			Présent		A améliorer	
			Oui	Non	Oui	Non
	2.4	Budget détaillé				
	2.5	Chronogramme				
3	Le(s) demandeur(s) ont signé la fiche d'engagement indiquant qu'il(s) s'engage(nt) à	• Respecter les principes éthiques et garantir la sécurité des participants				
		• Respecter les conditions d'obtention du consentement libre et éclairé				
		• Remettre le rapport de recherche un mois au maximum après la fin de ladite recherche				
		• Prendre en compte des amendements et recommandations éventuels du Comité National d'Ethique de la Recherche (CNERS)				
		• Informer le CNERS de la suspension ou de l'arrêt prématuré de la recherche, des raisons de cette suspension ou de l'arrêt, de la clôture d'une étude autorisée				
		• Se conformer aux BPC, BPR, BPF dans la mise en œuvre du protocole				
		• Coopérer avec le CNERS dans le suivi et les inspections des projets de recherche sur le terrain				

4	Le(s) demandeur(s) ont mentionné clairement dans le protocole	• S'ils indemnisent ou non les sujets se prêtant à la recherche				
		• S'ils remboursent ou non les frais et l'accès à des soins médicaux				
		• Toute décision antérieure défavorable ou demande de modification du protocole prises par d'autres Comités d'Ethique ou autorités réglementaires à propos de la recherche en question et indication du (des) changement(s) apporté(s) au protocole à cet égard				
		• Les raisons des précédentes décisions défavorables doivent être fournies.				
5	Dans le protocole le chercheur a indiqué comment et quand et dans quelles conditions il informe le CNERS	• S'ils étaient amenés(s) à modifier son protocole au cours de sa mise en œuvre, des conditions d'exécution et des outils de recherche après l'avis du CNERS				
		• Des événements indésirables graves ou inattendus liés à la conduite de la recherche ou au produit testé ;				
		• Des nouvelles mesures prises par les investigateurs, le promoteur et les organismes réglementaires ;				
		• De tout événement ou information nouvelle susceptible de modifier le rapport bénéfice/risque de la recherche				
6	Dans le cas où la recherche implique un produit à l'étude Le(s) demandeur(s) ont porté à la connaissance du CNERS	• Un résumé adéquat de toutes les données : - De tolérance ; - Pharmacologiques, pharmaceutiques ; - Toxicologiques du produit évalué.				
		• L'expérience clinique acquise à ce jour avec ce produit (ex : brochure investigateur récente, publications, résumé des caractéristiques du produit)				
		• Quand et comment il (s) compte (ent) gérer les cas d'échecs, par exemple				
		- Les critères/ constats d'échec à un traitement ont – ils été définis à l'avance ?				
		- Quelles sont les dispositions prévues pour ces cas d'échec, pendant ou après le déroulement de la recherche ?				

		• Quand et comment il (s) compte (ent) gérer certains évènements (risques probables encourus, connus à l'avance ou non) qui surviennent en cours de recherche ; par exemple				
		- Qui prend en charge le sujet qui fait l'objet de la recherche ? pour combien de temps ?				
		- On lui découvre une pathologie qu'il ignorait : qui le prend en charge ? pour combien de temps ?				

2.7. SEC7- Check- List Dépôt Protocole Recherche Biomédicale

☛ Fiche de vérification de la complétude du dossier de soumission de protocole de recherche biomédicale

Titre du projet :

Veuillez vérifier si les éléments suivants sont présents dans ce dossier de soumission du protocole.

N°	Nom du document	Présent	Absent	N/A
01	Lettre de soumission adressée au Président	☐	☐	☐
02	01 copie électronique du protocole en Français	☐	☐	☐
03	Une copie de la version originale du protocole (Anglais, Portugais, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Russe, etc.)	☐	☐	☐
04	01 copie du Formulaire de Consentement	☐	☐	☐
05	01 copie de la Fiche d'Information pour le consentement	☐	☐	☐
06	Budget détaillé en CFA	☐	☐	☐
07	Questionnaire (s)	☐	☐	☐
08	Cahier(s) d'Observation (CRF)	☐	☐	☐
09	01 copie Brochure de l'Investigateur	☐	☐	☐
10	01 copie copies du CV du PI daté et signé et ceux des autres membres de l'équipe de recherche	☐	☐	☐
11	1 copie de l'assurance souscrite par le Sponsor	☐	☐	☐
12	Fiche d'Engagement vis-à-vis du CNERS qui est signée et datée	☐	☐	☐
13	Lettres d'engagement des investigateurs impliqués dans le projet de recherche	☐	☐	☐
14	Copie d'Avis d'autre(s) Comités d'Ethique (si possible)	☐	☐	☐
15	Quitus des frais de soumission	☐	☐	☐

Le dossier de soumission est-il complet ?	Oui ☐	Non ☐
---	------------------------------	------------------------------

Date de Réception : /___/___/___/

Prénom et Nom du vérificateur :

Signature :

2.8. SEC8- Check- List Dépôt Protocole Sciences Sociales

☛ Fiche de vérification de la complétude du dossier de soumission de protocole en sciences sociales et humaines

Titre du projet :

Veuillez vérifier si les éléments suivants sont présents dans ce dossier de soumission du protocole.

N°	Nom du document	Présent	Absent	N/A
01	Lettre de soumission adressée au Président	☐	☐	☐
02	Une copie électronique du protocole en Français	☐	☐	☐
03	Une copie de la version originale du protocole (Anglais, Portugais, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Russe, etc.)	☐	☐	☐
04	01 copie du Formulaire de Consentement	☐	☐	☐
05	01 copie de la Fiche d'Information pour le consentement	☐	☐	☐
06	Budget détaillé en CFA	☐	☐	☐
07	01 copie des outils de collecte des données	☐	☐	☐
08	01 copie du CV du PI daté et signé et ceux des autres membres de l'équipe de recherche	☐	☐	☐
09	Fiche d'Engagement du chercheur vis-à-vis du CNERS qui est signée et datée	☐	☐	☐
10	Soumission du protocole à un autre Comité d'Ethique	☐	☐	☐
11	Lettres d'engagement des investigateurs impliqués dans le projet de recherche	☐	☐	☐
12	Quitus des frais de soumission	☐	☐	☐

Date de Réception : /___/___/___/

Prénom et Nom du vérificateur:

Signature :

2.9. SEC9- Check- List Dépôt Protocole Médecine Traditionnelle

☛ Fiche de vérification de la complétude du dossier de soumission de protocole en médecine traditionnelle

Titre du projet :

Veuillez vérifier si les éléments suivants sont présents dans ce dossier de soumission du protocole.

N°	Nom du document	Présent	Absent	N/A
01	Lettre de soumission adressée au Président	☐	☐	☐
02	Une copie électronique du protocole en Français	☐	☐	☐
03	Une copie de la version originale du protocole (Anglais, Portugais, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Russe, etc.)	☐	☐	☐
04	01 copie du Formulaire de Consentement	☐	☐	☐
05	01 copie de la Fiche d'Information pour le consentement	☐	☐	☐
06	Budget détaillé en CFA	☐	☐	☐
07	outils de collecte de données	☐	☐	☐
08	Cahier(s) d'Observation (CRF)	☐	☐	☐
09	Données sur le produit	☐	☐	☐
10	01 Copies du CV du PI daté et signé et ceux des autres membres de l'équipe de recherche	☐	☐	☐
11	Une copie de l'assurance souscrite par le Sponsor (s'il y'a lieu)	☐	☐	☐
12	Fiche d'Engagement du chercheur vis-à-vis du CNERS qui est signée et datée	☐	☐	☐
13	Soumission du protocole à un autre Comité d'Ethique	☐	☐	☐
14	Lettre d'engagement des investigateurs impliqués dans le projet de recherche	☐	☐	☐
16	20 Rapports de toxicologie	☐	☐	☐
17	Quitus des frais de soumission	☐	☐	☐

Date de Réception : / ____ / ____ / ____ /

Prénom et Nom du vérificateur:

Une fiche d'enregistrement et de suivi des réclamations est établie au niveau du secrétariat.

A chaque fois qu'un participant à une étude ou toute autre personne désirant recevoir ou transmettre des informations ou soumettre des réclamations à propos d'une étude, contacte le secrétariat qui est tenu de renseigner les différentes rubriques de la fiche.

Cette fiche comprend entre autres les rubriques suivantes :

- Nom, Prénom de la personne qui a appelé, lieu d'habitation, numéro de téléphone ;
- Nom de l'étude, nom de l'organisme qui la met en œuvre ;
- Nature de la demande ou information transmise et réponses données par le secrétariat.

Ces informations sont aussitôt portées à la connaissance du Secrétaire Permanent(SP) qui, en rapport avec le président, décide de la suite à donner avec mention sur la fiche établie à cet effet.

Les autres membres du CNERS lors des sessions ordinaires sont informés des réclamations suscitées par des études. Ils peuvent être saisis par email ou convoqués en session extraordinaire en cas d'urgence selon l'évaluation du SP en concertation avec le Président.

III. Annexes

3.1. Texte du serment des membres du CNERS et du secrétariat permanent

Les membres du CNERS, avant leur entrée officielle en fonction, prêtent devant la Cour d'Appel de Dakar siégeant en audience solennelle le serment dont la teneur suit :

« Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre du CNERS, en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations. »

Les autres agents membres du secrétariat permanent du CNERS prêtent serment devant le tribunal régional de Dakar en ces termes :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d'agent du secrétariat du CNERS » en toute indépendance et impartialité, et de garder le secret des sur tous documents relatifs au CNERS ainsi que sur les délibérations. »

3.2. Montants des frais de mission

Promoteur/Sponsor	Type de projet	Montant du projet (FCFA)	Frais de soumission (FCFA)
Société /Structure à but commercial	Essai clinique Nouvelles molécules/ /amendement majeur	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000 Forfait	2.000.000 1.000.000 500.000 250 000
	Essai clinique avec des molécules, traitements avec AMM	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	1.000.000 500.000 250.000
	Etude autre qu'essai clinique	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	500.000 250.000 150.000
Organisation à but non lucratif / Institut de recherche privé au Sénégal / Cabinet privé au Sénégal	Essai clinique Nouvelles molécules/	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	1.000.000 500.000 250.000
	Essai clinique avec des molécules, traitements avec AMM	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	500.000 250.000 200.000
	Etude autre qu'essai clinique	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 10.000.000<X <50.000.000 ≤10.000.000	300.000 200.000 150.000 100.000
	Etude pouvant faire l'objet d'une évaluation simplifiée /amendement majeur		75.000

Organisation à but non lucratif/ Institut de Recherche privé /universités à l'étranger	Essai clinique Nouvelles molécules/	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	1.500.000 1.000.000 500.000
	Essai clinique avec des molécules, traitements avec déjà AMM	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	1.000.000 500.000 250.000
	Etude autre qu'essai clinique	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 10.000.000<X <50.000.000 ≤10.000.000	500.000 250.000 200.000 150.000
	Etude pouvant faire l'objet d'une évaluation simplifiée/amendement majeur		100.000
Structures publiques/académiques nationales	Essai clinique Nouvelles molécules/	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	500.000 250.000 150.000
	Essai clinique avec des molécules, traitements AMM	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000	350.000 250.000 150.000
	Etude autre qu'essai clinique	≥100.000.000 50.000.000 < X<100.000.000 <50.000.000 ≤10.000.000	250.000 150.000 100.000 75.000
	Etude pouvant faire l'objet d'une évaluation simplifiée/amendement majeur		50.000

3.3. Loi n° 2009-17 Portant code d'éthique pour la recherche en santé

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Loi portant Code d'Éthique pour la Recherche en Santé

Exposé des motifs

La recherche en santé, selon la définition qui en a été donnée à la 43^e Assemblée mondiale de la Santé, est un processus visant à obtenir une connaissance systématique et des technologies pouvant être utilisées pour améliorer la santé des individus ou des groupes de population déterminés.

Elle fournit une information de base sur l'état de santé ou les pathologies de la population ; elle vise à mettre au point des outils pour prévenir et soigner la maladie, en atténuer les effets, et à concevoir des approches plus efficaces pour la prestation des soins de santé tant aux personnes qu'aux communautés.

Elle est donc une composante fondamentale de tout processus de développement durable d'un pays. Elle doit par conséquent se réaliser dans un contexte garantissant d'une part, la qualité scientifique de ses résultats, et d'autre part, le respect et la protection des personnes et des communautés concernées.

En outre, elle doit se conformer aux dispositions de la Constitution du Sénégal, de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et de l'ensemble des textes internationaux — Conventions, Déclarations et Résolutions — auxquels le Sénégal a souscrit.

Aujourd'hui, la recherche en santé au Sénégal est confrontée à un certain nombre de problèmes, notamment :

- l'absence de cadre législatif et réglementaire ;
- l'orientation de la recherche qui répond souvent aux exigences des pays du Nord ;
- la vulnérabilité des personnes participant à ces recherches ;
- la faiblesse des instances éthiques chargées de veiller au respect des droits des personnes participant aux recherches ;
- le partage inégal des résultats de la recherche.

Pour toutes ces raisons, le Sénégal doit disposer d'un code d'éthique pour la recherche en santé destiné notamment à :

- fixer les bases légales en vue du respect des principes éthiques dans la recherche en santé au Sénégal ;
- garantir le respect des droits des personnes et des groupes impliqués dans la recherche en santé ;
- encadrer la recherche en santé.

Les recherches qui font l'objet du présent code d'éthique sont notamment la recherche épidémiologique, la recherche biomédicale, la recherche sur les systèmes de santé, la recherche en médecine traditionnelle, ainsi que la recherche en sciences sociales et humaines.

Telle est l'économie du présent projet de loi.

Loi n° 2009-17 portant Code d'Éthique pour la Recherche en Santé

Titre I^{er} : Dispositions générales

Chapitre 1^{er} : Objet, champ d'application

Section 1 : Objet

Article 1^{er} : Objet de la loi

La présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles applicables à la recherche en santé.

Elle a pour but de protéger les personnes impliquées dans les recherches en santé.

Article 2 : Objet de la recherche en santé

La recherche en santé est un processus visant à obtenir une connaissance systématique et des technologies pouvant être utilisées pour améliorer la santé des individus ou des groupes de population déterminés.

Elle fournit une information de base sur l'état de santé ou les pathologies de la population ; elle vise à mettre au point des outils pour prévenir et soigner la maladie, en atténuer les effets, et à concevoir des approches plus efficaces pour la prestation des soins de santé tant aux personnes qu'aux communautés.

Section 2 : Champ d'application

Article 3: Toute recherche en santé entreprise sur le territoire national est régie par les dispositions du présent code.

Au sens de la présente loi, la recherche en santé comprend notamment :

- la recherche épidémiologique ;
- la recherche biomédicale ;
- la recherche en médecine traditionnelle ;
- la recherche sur les systèmes de santé ;
- la recherche en sciences sociales et humaines

Article 4 :

- La recherche épidémiologique est toute étude qui vise à mesurer les facteurs déterminant ou influençant la survenue ou la persistance d'un problème de santé dans une population donnée.

- La recherche biomédicale désigne les diagnostics, les essais ou expérimentations organisés et pratiqués directement sur l'être humain et/ou l'animal en vue du développement des connaissances médicales et pharmaceutiques.

- La recherche en médecine traditionnelle est celle qui s'intéresse aux pratiques de soins de santé employées par une population selon des traditions le plus souvent orales.

- La recherche sur les systèmes de santé est celle qui porte sur les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévention des maladies et les soins aux malades ainsi que sur les administrations, les personnes et les équipements qui y contribuent.

- La recherche en sciences sociales et humaines est l'étude de tous les facteurs sociaux et humains qui déterminent l'état de santé des personnes et des sociétés.

Article 5 : Toute personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche en santé a la qualité de promoteur. Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales prennent l'initiative d'une même recherche, elles désignent en leur sein une personne qui fait office de promoteur et assume les obligations correspondantes.

Article 6 : Toute personne physique qui conçoit et/ou dirige la réalisation d'une recherche en santé a la qualité de chercheur. Lorsque le promoteur confie la mise en œuvre d'une recherche à une équipe de chercheurs, il désigne parmi eux un chercheur principal.

Lorsque la recherche est entreprise par plusieurs équipes de chercheurs, celles-ci désignent en leur sein un coordonnateur.

Chapitre 2 : Principes éthiques de la recherche en santé

Article 7 : Toute recherche impliquant des sujets humains doit être menée dans le respect des principes énoncés ci-après :

- le consentement libre et éclairé de la personne à l'étude ;
- le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme ;
- un rapport « Effets bénéfiques » sur « effets nocifs » favorable au participant ;
- le respect de l'autonomie et de la responsabilité individuelle ;
- la prise en compte de la vulnérabilité humaine et le respect de l'intégrité physique et morale ;
- la prise en compte de l'égalité, de la justice et de l'équité dans l'élaboration et la mise en œuvre de l'étude ;
- la non-discrimination et la non-stigmatisation ;
- le respect de la diversité culturelle et du pluralisme ;
- la solidarité et la coopération ;
- le partage des bienfaits ;
- le respect de l'anonymat ;
- le respect de la vie privée et de la confidentialité ;
- la prise en compte des croyances et pratiques socioculturelles ;
- la restitution des résultats aux personnes concernées.

Article 8 : Préalablement à la réalisation d'une recherche en santé sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que le chercheur ou son représentant lui a fait connaître :

- l'objectif de la recherche,
- la méthodologie,
- la durée,
- les résultats attendus,
- les contraintes et les risques prévisibles, même en cas d'arrêt de la recherche avant son terme,
- l'avis éthique et scientifique du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS).

Le chercheur ou son représentant informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son adhésion à tout moment sans encourir aucun préjudice.

Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant du chercheur et du promoteur.

Article 9 : L'implication d'êtres humains, en tant que sujets de recherche, doit être subordonnée à la possibilité pour eux d'y consentir librement et en toute connaissance de cause.

Article 10 : Le consentement est dit libre lorsqu'il est donné de manière volontaire et en dehors de toute pression quelconque.

Article 11 : Le consentement éclairé à titre individuel des personnes participant à toute recherche en santé est obligatoire

Le consentement est dit éclairé lorsque la personne sollicitée comprend le but et la nature de la recherche, les obligations qu'implique sa participation à celle-ci, ainsi que les risques et les avantages qui peuvent en découler.

Article 12 : La recherche en santé ne peut s'effectuer sur une personne en état de mort cérébrale qu'avec son consentement préalablement exprimé par écrit ou par celui de sa famille ou de ses ayant droits.

Article 13 : L'utilisation du corps d'une personne décédée à des fins de recherche ne peut se faire qu'avec le consentement préalablement exprimé par le sujet de son vivant ou par celui de ses ayant droits.

Chapitre 3 : Des modalités de la recherche en santé

Article 14 : Les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct sont menées lorsqu'il en est attendu un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête

Toutes les autres recherches biomédicales portant sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct.

Article 15 : La recherche en médecine traditionnelle vise à :

- valider les propriétés thérapeutiques des plantes médicinales et extraits d'animaux et minéraux et leurs utilisations dans le traitement des différentes affections ;
- œuvrer efficacement pour la mise au point des produits de la médecine traditionnelle qui ont déjà fait leurs preuves thérapeutiques, tout en veillant à leur conditionnement hygiénique et à leur bonne conservation, en vue d'une utilisation à l'échelle nationale, régionale et internationale.

Article 16 : La recherche sur les systèmes de santé a pour but de favoriser la prise de décision rationnelle pour la gestion optimale des établissements et structures du système de santé.

Cette gestion vise à assurer, à moindre coût et avec une qualité meilleure de service, la promotion de la santé et la prestation de soins préventifs, curatifs, ré-adaptatifs et promotionnels aux différents niveaux du système.

Titre II : Conditions d'exécution et de régulation de la recherche en santé

Chapitre 1^{er} : Recherche épidémiologique

Article 17 : Toute recherche épidémiologique appliquée à un groupe d'individus ou à une communauté doit requérir l'accord préalable de ses représentants légaux.

Lorsqu'un groupe d'individus ou une communauté sur lequel porte l'étude doit être représenté par une personne mandatée, le chercheur doit s'assurer de l'authenticité de son mandat.

Le refus d'une participation individuelle à une telle recherche doit être libre et respecté.

Article 18 : Lorsque des groupes d'individus sont constitués à des fins d'une recherche à visée épidémiologique et qu'il n'est pas possible d'identifier leur représentant, le chercheur doit obtenir le consentement éclairé et libre de chacune des personnes appelées à participer à cette recherche.

En cas de recherche clinique et/ou biomédicale à mettre en œuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du Comité national d'éthique pour la recherche en santé peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus. L'intéressé sera informé dès que possible et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de la recherche.

Article 19: Le consentement éclairé n'est pas exigé dans le cas où :

- il est impossible de localiser des personnes participant à toute recherche dont les dossiers seront examinés ;
- il existe un risque de biais dans les résultats de certaines recherches où les personnes participant à une recherche sont susceptibles de modifier leurs comportements.

Chapitre 2 : Des recherches biomédicales

Article 20 : Les recherches clinique et biomédicale doivent être effectuées :

- sous la direction d'un chercheur qualifié ; au cas où il n'est pas médecin, il doit être assisté d'un médecin justifiant d'une expérience d'au moins cinq (05) ans dans le domaine concerné ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'étude et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.

Article 21 : Toute recherche biomédicale sur l'être humain doit :

- se fonder sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation pré-clinique suffisante ;
- procurer aux personnes concernées un bénéfice largement supérieur au risque prévisible encouru ;
- viser à étendre les connaissances scientifiques sur l'être humain et les moyens susceptibles de maintenir ou d'améliorer son état de santé.

Article 22 : Les mineurs et les majeurs protégés par la loi admis dans un établissement sanitaire ou social ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé et après avis du père et/ou de la mère, du tuteur ou du curateur.

Toutefois, ils peuvent être l'objet de recherches sans bénéfice individuel direct au cas où celles-ci remplissent les conditions suivantes:

- ne présenter aucun risque prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de sexe et d'état de santé ;
- ne pas pouvoir être réalisées autrement.

Article 23 : Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi, le consentement doit être donné :

- par le titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, pour les mineurs non émancipés ;
- par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas de risque prévisible, pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi ;
- par le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles, dans les autres cas.

Article 24 : La recherche biomédicale exige la souscription préalable par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur.

Article 25 : La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais auxquels elles sont exposées et sous réserve de dispositions particulières prises par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé.

Article 26 : La recherche biomédicale avec ou sans bénéfice individuel direct ne doit comporter aucun risque prévisible pour la santé des personnes qui s'y prêtent.

Article 27 : La recherche biomédicale sans bénéfice direct doit être précédée d'un examen médical des personnes concernées effectué par un médecin désigné par le chercheur principal ou le coordonnateur.

Article 28 : Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.

Article 29 : La recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct doit être réalisée dans un lieu équipé de moyens matériels et techniques appropriés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent. Le site de recherche ainsi défini doit être conforme aux normes définies par voie réglementaire.

Article 30 : Toute recherche biomédicale avec ou sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent doit remplir les conditions suivantes :

- être dénuée de tout risque prévisible mettant en cause le pronostic vital ou entraînant une incapacité permanente de la mère et/ou de l'enfant ;
- être utile à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement ;
- ne pouvoir être réalisée autrement.

Article 31 : L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies géniques ou cellulaires, n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent code.

Article 32 : Par dérogation aux dispositions du présent code, les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en œuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la santé sur avis du Comité national d'éthique pour la recherche en santé.

Article 33 : Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules des animaux sont fixées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'élevage, sur proposition du Comité national d'éthique pour la recherche en santé.

Article 34 : Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et de l'élevage fixent :

- les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
- les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent des organes, tissus et cellules utilisés ;
- les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.

Chapitre 3 : Recherche en médecine traditionnelle

Article 35 : La recherche en médecine traditionnelle doit être effectuée :

- sous la direction d'un chercheur qualifié et, au cas où il n'est pas médecin, assisté d'un médecin et/ou d'un pharmacien et ou d'un chirurgien dentiste justifiant d'une expérience avérée dans le domaine concerné et d'un tradipraticien, sur la base d'une collaboration préalable matérialisée par un accord écrit ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à la recherche et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à cette recherche.

Article 36 : Toute recherche en médecine traditionnelle sur l'être humain doit :

- se fonder sur une évaluation ethno-médicale ;
- procurer aux personnes concernées un bénéfice supérieur au risque prévisible encouru ;
- viser à étendre les connaissances scientifiques sur l'être humain et les moyens susceptibles de maintenir ou d'améliorer son état de santé ;
- obtenir l'accord du comité national d'éthique pour la recherche en santé.

Chapitre 4 : Recherche sur les systèmes de santé

Article 37 : Toute recherche sur les systèmes de santé doit requérir :

- la participation active des professionnels de la santé et des gestionnaires du système de santé ;
- l'accord et la participation des individus, des groupes et communautés concernés ;
- l'accord préalable du Comité national d'éthique pour la recherche en santé.

Chapitre 5 : Recherche en sciences sociales et humaines

Article 38 : La recherche en sciences sociales et humaines vise à analyser les institutions qui régissent le comportement humain : famille, parenté, système de cultures, régime politique, culte religieux, interactions avec les systèmes de soins. Il est entre autres, l'art de découvrir la clef cachée de toutes les conduites humaines, les plus manifestes comme les moins avouées.

Article 39 : La recherche en sciences sociales et humaines ne peut être effectuée que par les chercheurs qui remplissent les conditions suivantes :

- être titulaire d'une maîtrise en sciences sociales et avec une expérience d'au moins cinq (05) ans ;
- disposer de conditions matérielles et techniques adaptées à l'étude et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches,
- avoir le consentement éclairé des individus et/ou l'accord des groupes et communautés concernés,
- avoir l'accord préalable du Comité national d'éthique pour la recherche en santé (CNER).

Chapitre 6 : Régulation de la recherche en santé

Article 40 : Il est créé un organe de régulation appelé Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNER) doté d'une personnalité juridique. Il est placé sous la tutelle administrative du Ministère de la Santé et sous la tutelle financière du Ministère de l'Économie et des Finances.

Article 41 : Un décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé, fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du Comité national pour la recherche en santé.

Titre III Dispositions pénales

Article 42 : Quiconque pratique ou fait pratiquer sur une personne une recherche biomédicale, une recherche en médecine traditionnelle ou une recherche en sciences sociales et humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d'une amende de cent mille (100 000) francs à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables lorsque le consentement a été retiré avant qu'il ne soit procédé à la recherche.

La peine encourue lorsqu'il s'agit d'une personne morale est une amende de trois millions (3 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs.

Article 43: Quiconque pratique ou fait pratiquer une recherche biomédicale ou en médecine traditionnelle en infraction aux dispositions des articles 26 à 28 du présent code, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million cinq cent mille (1 500 000) francs.

Article 44 : Outre les peines prévues à l'article 42 et 43 du présent code, le coupable encourt les sanctions suivantes :

- l'interdiction à temps des droits civiques suivant les dispositions du code pénal ;
- l'interdiction pour une durée de deux (02) à cinq (05) ans, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- la confiscation du corps du délit ;
- l'exclusion de la soumission aux appels d'offres pour l'attribution des marchés publics pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans.

Article 45 : Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et d'une amende de cent mille (100 000) francs à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche clinique et/ou biomédicale et une recherche en médecine traditionnelle en violation du respect de la confidentialité prévu à l'article 7 du présent code ;
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche clinique et/ou biomédicale et une recherche en médecine traditionnelle sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par les articles 32, 36, 37, 39 du présent code ;
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche clinique et/ou biomédicale et/ou une recherche en médecine traditionnelle dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé.

Article 46 : Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article 24 du présent code est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d'une amende de trois cent mille (300 000) francs à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 47 : Quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer sur une personne une recherche clinique et/ou biomédicale et une recherche en médecine traditionnelle autorisées mais ayant entraîné un homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) francs à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 48 : Quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer sur une personne une recherche biomédicale ou une recherche en médecine traditionnelle autorisée mais ayant causé des blessures involontaires ou une maladie ayant entraîné par défaut d'adresse ou de précaution d'une incapacité temporaire de travail pour le sujet est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à douze (12) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) francs à deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 49 : Quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer sans le consentement du sujet ou sans l'avis du Comité national d'éthique pour la recherche en santé une recherche biomédicale, une recherche en médecine traditionnelle ou une recherche en sciences sociales et humaines ayant entraîné la mort du sujet sera puni d'une réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans.

La peine sera, s'il y a une incapacité de travail de 21 jours ou un handicap physique ou mental, de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) francs à deux cent cinquante mille (250 000) francs.

Titre IV : Dispositions finales

Article 50 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Dakar, le 09 Mars 2009-03-26

Abdoulaye Wade

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Cheikh Hadjibou Soumaré

3.4. Décret n° 2009-729 du 3-08-2009 créant le Comité d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS)

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

N°2009-729 du 3-8-2009

Décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS)

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’ordre des médecins ;
Vu la loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 portant code de déontologie des pharmaciens ;
Vu la loi n° 81-70 du 10 décembre 1981 portant ordre des chirurgiens dentistes ;
Vu la loi n° 90-07 du 28 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales du droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
Vu la loi n° 2009-17 du 9 mars 2009 portant code d’éthique de la recherche en santé ;
Vu le décret 2004-583 du 30 avril 2004 relatif aux attributions du Ministère de la Santé ;
Vu le décret 2004-1404 du 4 novembre 2004 portant organisation du Ministère de la Santé et de la Prévention médicale ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’État et du contrôle des Établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié par le décret n° 2009-628 du 13 juillet 2009 ;
Vu le décret n° 2009-548 du 9 juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ministre, nommant un nouveau ministre et fixant la composition du Gouvernement ;

Sur le rapport du Ministre de la Santé, de la Prévention et de l’Hygiène publique ;

Décète

Chapitre Premier. — Dispositions générales

Article premier. — Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé en application des dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 2009-17 du 9 mars 2009 portant code d’éthique pour la recherche en santé.

Chapitre 2. — Missions et attributions

Article 2. — Le Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé a pour mission :

- d’examiner les protocoles de recherche en santé en vue d’assurer :
 - la protection des personnes qui se prêtent à la recherche ;
 - la qualité scientifique et éthique des protocoles de recherche ;
- d’émettre un avis éthique et scientifique en vue de fonder la décision du ministre chargé de la santé d’autoriser, de suspendre, ou d’interdire la poursuite d’une recherche ;
- de vérifier sur le terrain, s’il y a lieu, le respect des principes éthiques dans les recherches en santé autorisées ;
- de conduire et de développer la réflexion sur les aspects éthiques et juridiques suscités par la pratique de la recherche en santé ;
- de promouvoir l’éducation, la formation et l’information en éthique de la recherche chez les personnels de santé et les populations.

Article 3. — Le Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé veille à la protection des droits et du bien-être de toute personne ou communauté impliquée dans une recherche en santé. Il doit, préalablement à la réalisation d'une recherche en santé pour laquelle il donne un avis, prendre en considération :

- les risques prévisibles
- les bénéfices attendus
- les modalités de recueil du consentement éclairé des personnes ;
- les garanties particulières pour la protection des personnes soumises à une contrainte ou sous influence.

Chapitre 3. — Composition

Article 4. — Le Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé comprend trente deux (32) membres répartis ainsi qu'il suit :

1. Le Directeur chargé de la recherche en santé ou son représentant
2. Deux représentants du ministre chargé de la santé
3. Un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique
4. Un représentant du ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé, des Langues nationales et de la Francophonie
5. Un juriste représentant la faculté de droit
6. Un représentant de l'Institut des droits de l'homme et de la paix
7. Deux enseignants de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie :
 - un enseignant spécialisé en médecine légale
 - un enseignant spécialisé dans la pharmacologie
8. Un représentant de l'ordre des médecins
9. Un représentant de l'ordre des pharmaciens
10. Un représentant de l'ordre des chirurgiens dentistes
11. Un représentant du Conseil national des tradipraticiens
12. Un spécialiste en santé publique, expert en épidémiologie
13. Une personnalité appartenant à une institution de recherche en santé
14. Le Directeur des établissements de santé ou son représentant
15. Un expert en sciences sociales
16. Un représentant de l'Académie des Sciences et Techniques
17. Un représentant du barreau
18. Un représentant des professions paramédicales
19. Un représentant du Centre africain de Recherche appliquée (CARA)
20. Un représentant de la confession musulmane
21. Un représentant de la confession chrétienne
22. Un représentant de la société civile
23. Un représentant du Sénat
24. Un représentant de l'Assemblée nationale
25. Cinq personnalités désignées à qualités par le ministre chargé de la Santé
26. Un représentant de la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires.

Article 5. — Les experts extérieurs au CNERS seront désignés selon les spécificités des protocoles de recherche soumis.

Article 6. — Les membres du CNERS sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Article 7. — Le CNERS comprend (3) commissions animées par un Secrétariat qui est défini par arrêté ministériel. Les commissions sont les suivantes :

- Commission chargée du suivi des protocoles ;
- Commission chargée de la formation et de la sensibilisation en éthique de la recherche ;
- Commission finances et comptabilité.

Chapitre 4. — Fonctionnement

Article 8. — Le Président du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé pour une durée de quatre ans, parmi les membres du Comité. Son mandat est renouvelable une fois.

Article 9. — Le CNERS choisit en son sein un vice-président qui est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 10. — Le mandat des membres du CNERS est de quatre ans, renouvelable au ¾ une seule fois. En cas de décès, de démission ou d'incapacité dûment constatée d'un membre du CNERS en cours de mandat, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que sa nomination. Le remplacement définitif doit être effectué dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de cessation de l'activité.

Article 11. — Le CNERS peut siéger valablement si la majorité absolue des membres convoqués est présente. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première session, le président convoque une deuxième session sous huitaine. À l'occasion de cette session, le CNERS délibère, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations ne sont valables que si les catégories professionnelles et institutionnelles suivantes sont représentées :

- le ministère chargé de la santé
- un des ordres des professions médicales
- la profession juridique
- les sciences humaines et sociales.

Article 12. — Le CNERS se réunit en assemblée ordinaire tous les deux mois. Il peut également au besoin tenir des sessions extraordinaires.

Les décisions sont prises par consensus ou à défaut, par un vote au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des membres présents.

Nul membre ne peut être représenté à une réunion du CNERS.

Article 13. — Les promoteurs, les chercheurs et les membres de leur famille ne peuvent pas participer à l'examen du protocole les concernant, sauf à la demande du CNERS pour fournir des informations.

Article 14. — Le CNERS peut être appelé par son président à siéger entre deux sessions à la demande des 2/3 de ses membres ou du ministre chargé de la Santé pour examiner tout cas concernant les droits et le bien-être de tout sujet impliqué dans une recherche en santé.

Article 15. — Les modalités de gouvernance par type de recherche sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Article 16. — Dès qu'il en a connaissance, le CNERS informe le ministre chargé de la Santé et le promoteur de la recherche :

- de tout accident ou incident grave imprévu pour les sujets se prêtant à la recherche ou les populations du site ;
- de la non-observance grave ou répétée des dispositions du Code d'Éthique de la Recherche en Santé.

Article 17. — Les séances du CNERS ne sont pas publiques. Les membres du CNERS et le secrétariat sont tenus au secret des débats et des délibérations. Ils prêtent serment devant le tribunal avant leur prise de service.

Article 18. — Le CNERS peut solliciter l'avis d'un expert sur tout point inscrit à l'ordre du jour.

Article 19. — Les avis et recommandations du CNERS concernant l'examen et l'agrément des protocoles sont adressés au ministre chargé de la santé qui prend une décision à communiquer au promoteur.

Le CNERS envoie les avis éthiques et scientifiques au promoteur.

Les activités du CNERS font l'objet d'un rapport annuel transmis au ministre chargé de la Santé.

Article 20. — Le CNERS prépare et tient à jour une documentation qui comprend pour chaque protocole étudié le procès-verbal de la séance et les différentes correspondances y afférents.

Article 21. — Le CNERS dispose d'un secrétariat permanent nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé. Ce dit secrétariat reçoit tous les protocoles et organise la circulation entre les membres du CNERS et les chercheurs.

Chapitre 4. — Mise en œuvre de la régulation

Article 22. — L'examen de tout protocole de recherche s'appuie sur les outils d'évaluation validés par le CNERS.

Article 23. — Lorsque la proposition de recherche est initiée de l'extérieur par un organisme, elle doit être accompagnée de l'avis du Comité d'Éthique du pays initiateur ou de toute autre structure tenant lieu, avant son examen par le Comité national d'Éthique pour la recherche en santé

Chapitre 5. — Dispositions financières

Article 24. — Les ressources du CNERS proviennent du budget de l'État, des frais de soumission des protocoles fixés par le CNERS et des appuis des partenaires au développement.

Les ressources du CNERS sont dépensées selon les rubriques ci-après :

- suivi et évaluation sur le terrain des protocoles de recherche mis en œuvre ;
- prise en charge par les membres du CNERS lors des réunions d'examen de protocole ;
- achat de fournitures et d'équipement de bureau ;
- soutien logistique ;
- indemnités mensuelles de motivation de l'équipe de secrétariat.

Chapitre 5. — Dispositions finales

Article 25. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 26. — Le Ministre de la Santé, de la Prévention et de l'Hygiène publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel*.

Fait à Dakar, le 3 août 2009

Abdoulaye Wade.

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné Ndiaye

Rapport de présentation

L'état actuel de la recherche biomédicale et comportementale a permis de noter une amélioration importante de la santé des populations sénégalaises. Cependant, plusieurs événements et faits récents suscitent des inquiétudes qui justifient la mise en place d'un système de surveillance éthique pour la recherche en santé, en l'occurrence le Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé (CNERS). Parmi ceux-ci, on peut noter :

- l'interprétation et l'application biaisée du principe de consentement éclairé, marquées par l'extrême vulnérabilité d'une grande partie de la population pauvre et analphabète ;
- les essais sur les méthodes de prévention de certaines pandémies avec l'introduction du placebo ayant pour effet de reléguer au second plan le droit aux soins équitables des populations ;
- les essais vaccinaux introduits de façon frauduleuse dans les programmes légaux sanitaires ;
- les nombreux risques liés :
 1. à la multiplication des études sur le génome,
 2. à l'introduction des aliments génétiquement modifiés,
 3. aux risques d'épidémie de grippe aviaire,
 4. aux essais nouveaux de transplantation ou de greffe d'organes.

Face à ces défis, le rôle de l'État, à travers le Ministère de la Santé, de la Prévention et de l'Hygiène publique, est de créer et de renforcer les mécanismes d'évaluation éthique par la mise en place d'un comité d'éthique dont les missions visent à :

1. mener une réflexion éthique adaptée sur les progrès dans les sciences de la santé ;
2. jouer un rôle de conseil dans la formulation des principes directeurs de l'éthique, et à donner des avis circonstanciés ;
3. favoriser l'éducation, la formation et l'information, tant chez les spécialistes que chez le grand public ;
4. vérifier sur le terrain, s'il y a lieu, le respect des principes éthiques dans les recherches en santé.

Ce comité interviendra, en ses séances de travail consacrées à l'examen de protocoles soumis selon la réglementation visée par le présent décret, de façon à émettre un avis éthique et scientifique au ministre chargé de la Santé en vue de l'autorisation, de la suspension, ou de l'interdiction de la poursuite d'une recherche.

Le présent projet de décret a pour objet de préciser les missions, les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité national d'Éthique pour la Recherche en Santé ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa régulation.

Le Ministre de la Santé, de la Prévention et de l'Hygiène publique

Thérèse Coumba Diop

3.5. Organigramme du CNERS

